



台灣兒童青少年 神經多樣性第三屆國際研討會

— Third Taiwan Children and Adolescent
Neurodiversity International Symposium —

活動時間 115年9月12日(星期六)上午8:30 至 下午5:30

活動地點 亞東紀念醫院南棟14樓國際會議廳



台灣兒童青少年神經多樣性

第三屆國際研討會

Taiwan Children and Adolescent Neurodiversity International Symposium

目錄

研討會宗旨-----	2
議程表-----	3
前言-----	5
講師介紹-----	10
主題演講簡報-----	20



電子手冊 QR Code

研討會宗旨

兒童青少年的神經發育具有多樣性，不同的學習方式、情緒反應、人際互動與生活節奏，都需要被理解並獲得適切支持。隨著社會對神經多樣性的認識逐步深化，下一階段更重要的課題，是如何讓醫療、心理、教育、老師與家庭所提供的專業協助，真正延伸到孩子每天的生活之中。

「台灣兒童青少年神經多樣性國際研討會」邁入第三屆，從最初認識神經多樣性、重新思考如何以更具包容性的制度回應差異，今年進一步聚焦於「從專業支持走向生活實踐」，探討神經多樣性兒少在家庭、醫療、社區、學校及成長過程中所需要的具體支持。

本屆研討會邀集台灣、美國及日本專家，分享神經多樣性臨床照護、家庭理解、社區心理學，以及青少年生活技能與轉銜等經驗，並延續前屆所介紹的「生活陪跑師（Life Skill Coach）」概念，進一步探討如何透過實務陪伴、關係建立與技能培養，協助青少年將治療、諮商及專業建議實際運用於日常生活，提升支持的參與及效益。

我們期待透過跨國、跨專業的交流，持續累積可落實於台灣的實務經驗，讓神經多樣性兒少所獲得的支持，不只存在於診間或單一服務之中，而能串聯家庭、醫療、教育與社區，逐步建立更貼近孩子生活與成長需求的支持網絡。

議程表 Agenda-上午

時 間	TOPIC /演講主題
08:00-08:30	Registration / 報到
08:30-08:45	Opening remarks / 主辦 / 貴賓致詞
08:45-09:15	Neurodiversity — An Evolution of the Concept 神經多樣性的概念與演化 Dr. Raymond Sui-Hing Yan 甄瑞興醫師 / 台灣青少年神經多樣性行動協會理事長暨 亞東紀念醫院兒少神經多樣性共照中心主任
09:15-09:45	Understanding Children and Adolescent Neurodiversity in Home Environment 理解家庭中神經多樣性兒童青少年 Dr. Lin, Yu-Ju 林育如醫師 / 亞東紀念醫院兒童發展中心主任
09:45-10:35	From Mental Health to Life Skills Coach 從心理健康支持到生活陪跑師：日常生活技能的培養 Barry Fell / 美國猶他州 Telos 北校區執行總監
10:35-10:45	Coffee break 休息時間
10:45-11:35	Neurodiversity Clinical Excellence 神經多樣性卓越臨床照護實務 Drew Davis / 美國猶他州 Telos 北校區臨床總監
11:35-12:00	Panel Discussion 綜合討論
12:00-13:00	Lunch Time 午餐時間

議程表 Agenda-下午

時 間	TOPIC /演講主題
13:00-13:40	Autism, Neurodiversity, and Communities of Belonging: A Community Psychology Perspective 自閉症、神經多樣性與社區歸屬感：社區心理學的視角 Dr. Toshiaki Sasao 笹尾敏明 / 日本東京國際基督教大學社區心理學榮譽教授
13:40-14:30	A Day in the Life of Residential Treatment 住宿型治療機構的日常運作與照護實務 Barry Fell / 美國猶他州 Telos 北校區執行總監
14:30-15:20	The Telos Processing Approach 信息處理方法的諮商實務 Drew Davis / 美國猶他州 Telos 北校區臨床總監
15:20-15:30	Coffee Break 休息時間
15:30-16:20	Therapy: How to Get the Most Out of Therapy 如何提升諮商治療的參與及效益 Barry Fell / 美國猶他州 Telos 北校區執行總監
16:20-17:10	Influencing Adolescents Through Relationships, Understanding, and Skill Development 如何透過關係、理解和技能發展影響青少年 Drew Davis / 美國猶他州 Telos 北校區臨床總監
17:10-17:25	Panel Discussion 綜合討論
17:25-17:30	Closing 閉幕



邱冠明 醫師

亞東紀念醫院 院長

看見獨特，溫柔共照： 讓每個孩子走出自己的路

各位關心兒少發展的醫護同仁、教育專家、家長夥伴，以及遠道而來的國際貴賓：

大家好！秋風徐引的季節，我們帶著滿腔的熱忱與關懷，共同迎來了「台灣兒童青少年神經多樣性第三屆國際研討會」。看著現場與線上匯聚了這麼多專注而溫暖的眼神，心中除了感動，更有著無限的感謝與期許。

面對兒童青少年的成長與發展，我們愈來愈清楚看見，每一個孩子理解世界、與人互動、學習及生活的方式，本來就可能不同。神經多樣性的觀點提醒我們，支持孩子的目的，不是要求他們改變自己，去適應一套被視為「正常」的標準，而是重新思考醫療、教育與社會制度，如何理解不同的發展特質，並提供真正符合孩子需求的支持。

從 2024 年開始，三屆研討會一路走來，我們從「認識神經多樣性」開始，希望讓更多人理解，孩子看似不合作、不專心或難以融入的表現背後，可能有不同的神經發展特質；接著進一步思考，當我們真正看見差異之後，現有的醫療、教育與支持制度，是否也能重新設計，建立更具彈性與支持性的環境。去年研討會首次將「生活陪跑師（Life Skills Coach）」的制度與國際經驗帶進台灣，讓我們開始思考，如何協助青少年把專業建議真正落實於每天的生活。今年第三屆，我們希望再往前走一步，讓「理解差異」不只停留在理念，而能逐步轉化為實際的照護與支持模式。

今年，新北市政府衛生局更率先與亞東紀念醫院合作推動新北市第一間「兒少神經多樣性共照示範中心」，透過跨專業整合與個案支持，協助兒少及家庭銜接醫療、教育與社會資源。我們期待以新北市作為起點，逐步累積實務經驗，發展成為可供其他地區參考的示範模式。這樣的推動，也正深刻呼應了賴清德總統推動「健康臺灣」願景下的「健康臺灣深耕計畫」。其中，範疇四「社會責任醫療永續」強調以社區醫療為基礎整合照護體系、提升醫療資源的可及性與公平性。面對現今兒少多元的需求，醫院應從自身專業出發，透過跨專業、跨系統合作，回應孩子離開診間後，如何在家庭、校園與生活中持續成長，讓醫療支持能與日常生活更緊密連結。

這份共照網絡的築起，是一場跨越國界與專業的溫柔革命。我們特別感謝遠道而來的美國與日本專家，跨越海洋為我們帶來精準的臨床照護與社區心理學視角，豐富了台灣的實踐方法。在醫療、教育、社政與家庭間的緊密合作下，專業才能真正延伸到孩子每天面對的生活情境。

每一個「不一樣」的孩子，都是世界上獨一無二的星光。感謝一路上有您們的堅守與同行，因為有您們的信任，我們才有了無畏前行的勇氣。讓我們繼續用理解點亮獨特，持續累積更具體的實踐方法，溫柔攜手為孩子們鋪就一條充滿包容、能走出屬於自己成長道路的未來。

最後，衷心祝願大會圓滿成功，也祝福每一位夥伴身體健康、平安順心！



甄瑞興 醫師

台灣青少年神經多樣性行動協會 理事長

亞東紀念醫院兒少神經多樣性共照中心 主任

台灣青少年神經多樣性行動協會成立以來，我們始終相信：不同，不應該成為孩子被排除的理由，而應該成為我們重新思考支持方式的起點。

在第一線，我們常看到，有些孩子因為情緒調節、社交互動或學習節奏與別人不同，被誤解為「不合群」、「不配合」，甚至是「故意搗亂」；當孩子真正遇到困難時，也未必會直接說出「我需要幫助」，而可能透過睡眠、身體不適、拒學或人際挫折，表達正在面對的壓力。這些經驗不斷提醒我們，重要的不是要求孩子改變自己，去符合我們所認為的「正常」，而是大人與支持系統能不能更早看見他的不同、理解他的需求。

因此，過去幾年，我們持續透過國際研討會、專業交流與制度倡議，推動社會對神經多樣性 (Neurodiversity) 的認識。去年，我們首次將國際「生活導師 (Life Coach)」制度帶進台灣，當時以「生活導師」的名稱，介紹這個介於醫療、教育與家庭之間的支持角色，希望協助青少年把治療、諮商或教育中所學到的方法，真正運用在每天的生活。

今年第三屆國際研討會，我們希望再往前一步，從「認識生活陪跑師」走向「如何真正做好陪伴」。議程從日常生活技能培養出發，進一步討論住宿型治療照護、信息處理、提升諮商治療參與及效益，以及如何透過關係、理解與技能發展陪伴青少年，讓專業支持真正進入孩子的日常生活。

今年對協會而言，也不只是一場研討會。自 2026 年 9 月 14 日起，我們將與新北市政府社會局共同推動「全國神經多樣性生活陪跑師基礎概念訓練計畫」，希望將國際經驗進一步轉化為台灣可以培育、實踐並持續累積經驗的支持模式，讓更多第一線工作者、家屬、照顧者具備陪伴神經多樣性兒少的能力。

孩子的成長從來不是一條直線，也不應以單一標準衡量。期待透過今年的國際研討會與生活陪跑師培訓課程，讓「理解不同」不再只是一個理念，而能真正成為孩子與家庭在生活中感受得到的支持。



王瀚陽

國教行動聯盟 理事長

每個孩子的大腦運作方式不同，均值得被理解與尊重。近十年來，自閉症光譜、ADHD 與學習障礙等隱性特質的辨識率顯著提升，反映社會對神經多樣性的理解正逐步推進。

然而，孩子「被看見」的速度，已遠超越制度「接住」他們的能力。教育現場的教師在班級公平與個別需求間拉扯，家長也在社會誤解中孤軍奮戰。

為回應此缺口，我們連續三年舉辦神經多樣性國際研討會，引進美日實務經驗，並自 2025 年起倡議「台灣版生活導師」制度，期望在醫療、學校與家庭之間，建立起長期陪伴與資源整合的關鍵橋樑。

肯認差異，不代表否認困難。這群孩子真正需要的，是從「被看見」跨越到「被看懂」——需要能看懂孩子的老師、獲得支持的家長、願意接納的同儕，以及能彈性回應需求的制度。

願這場研討會成為更多「看得懂的大人」的起點，陪每一個孩子在理解與支持中，找到屬於自己的成長方式。



林月琴

立法委員

從長期投入兒童權利與兒少政策工作，到進入立法院推動相關制度改革，我始終認為，每一個孩子都應該依照自己的特質與需求，獲得適切的支持與平等發展的機會。對神經多樣性的兒童青少年而言，他們需要的不是被要求改變自己，去符合一套被視為「正常」的標準，而是我們的制度能不能真正看見差異，並提供符合不同需求的支持。

神經多樣性兒少所面對的挑戰，往往不只存在於單一場域。從醫療照護、校園學習、家庭支持，到人際互動與社區生活，都涉及衛生、教育、社政等不同體系。當制度彼此缺乏連結，最辛苦的往往是孩子與家庭，必須自行在不同資源間尋找協助。因此，如何讓服務彼此銜接，建立一套能夠陪伴孩子持續成長的支持網絡，是政策必須正視的重要課題。

過去，我曾在立法院與醫療、教育及民間團體共同推動「生活陪跑師（Life Coach）」支持模式，也持續關注第一線教師支持、兒少心理健康服務資源，以及醫療、教育與社政體系之間的合作與銜接。這些經驗更讓我確信，神經多樣性的孩子不應等到「適應不了」既有制度之後才被看見，而應從政策與服務設計之初，就將不同孩子的需求納入考量。

在立法院，我也會持續透過法規制度、預算資源、政策監督及跨部會協調，推動兒少支持體系更加完整，讓醫療端能及早提供適切協助、教育現場有足夠資源支持孩子，家庭在需要幫助時也能獲得相應服務，逐步補足不同制度之間的落差。

我相信，真正友善的兒少政策，不是要求每一個孩子都走同一條路，而是讓制度有能力理解不同、接住不同。未來，我也會持續從兒少權利出發，讓每一個孩子無論具有什麼樣的特質，都能被理解、被支持，並擁有安心成長與發展潛能的機會。



陳培瑜

立法委員

過去，我曾擔任學校國文老師，也曾從事親職教育工作。在與孩子及家長相處的過程中，我深刻感受到，理解孩子的特質，是陪伴孩子成長非常重要的第一步。對家長而言，如何認識孩子、理解孩子的需要，進一步找到適合的陪伴方式，是一段需要學習，也需要社會共同支持的旅程。

擔任立法委員後，我也持續從教育政策的角度關注神經多樣性兒少所面臨的處境。在學習與成長的過程中，他們可能需要更多元的教學方式、特教支持、心理輔導、交通協助或其他資源；而對第一線教師來說，如何更了解不同孩子的特質，也需要更多專業知能與支持。

教育的目標不應只是要求孩子適應既有的制度，而是讓制度也願意為不同的孩子調整。過去，我曾要求教育部持續提升教師的特殊教育知能，也關注有需求學生在教學、交通及心理輔導等方面的支持。同時，我也持續倡議強化家庭教育，希望讓家長獲得更多實用的資訊與資源，不必獨自面對教養過程中的困難。

我認為每一個孩子在成長方式、學習速度、思考習慣或與人互動的方式各有不同，但他們都是獨一無二的個體。藉由這次研討會，我希望與不同領域的學者、專家交流，透過更多的理解、對話以及政策的推動，創造更友善、更彈性讓每一個孩子都能被看見、被理解的環境！

講師介紹



林育如 醫師

亞東紀念醫院兒童發展中心 主任

現任

- 亞東醫院兒童發展中心主任
- 亞東醫院精神暨心身醫學部主治醫師
- 台大精神醫學部兼任主治醫師
- 台大醫學院精神科兼任副教授
- 教育部審定助理教授

經歷

- 台大醫院精神醫學部兒童心理衛生中心主治醫師
- 台大醫院精神醫學部兒童心理衛生中心研修醫師
- 台大醫院精神醫學部住院醫師/總醫師

主治項目

- 兒童青少年情緒行為問題、兒童心智問題
(注意力缺失過動症、自閉症, 情緒障礙, 學習障礙, 強迫、畏懼等)
- 發展遲緩
(語言、認知、社會情緒)
- 成人一般精神疾病
(失眠、焦慮、憂鬱、躁鬱、強迫症、思考障礙、調適障礙、幻覺、注意力不足、社交障礙)



Barry J. Fell, MSW, LCSW

EXECUTIVE PROFILE

Licensed Clinical Social Worker and Executive Director with over 25 years of experience in adolescent behavioral healthcare, residential treatment, clinical leadership, program development, and organizational management. Proven track record of leading multidisciplinary teams, developing high-performing treatment programs, managing complex budgets and operations, and driving strategic initiatives that improve clinical outcomes, customer satisfaction, and organizational growth. Recognized for expertise in adolescent mental health, family systems, executive leadership, staff development, risk management, and therapeutic program design.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Telos Academy | Orem, Utah

Executive Director | July 2016 – Present

Provide executive leadership for a nationally recognized residential treatment and therapeutic boarding school serving adolescents and families.

Key Responsibilities:

- Provide strategic oversight for all clinical, academic, residential, nursing, admissions, and operational departments.
- Direct organizational budgeting, financial stewardship, and resource allocation.
- Lead and supervise department directors and senior leadership team members.
- Develop and implement organizational strategy, long-term planning, and growth initiatives.
- Oversee quality assurance, compliance, accreditation standards, and risk management systems.
- Guide customer service initiatives and family engagement efforts to improve satisfaction and outcomes.
- Support admissions, enrollment strategy, and marketing efforts.
- Develop organizational culture, leadership training, and staff development systems.
- Lead crisis management, incident review, and continuous improvement processes.
- Monitor key performance indicators and operational metrics to ensure organizational effectiveness.

Notable Contributions:

- Led the organization through significant periods of growth and operational development.
- Strengthened leadership accountability systems and cross-department collaboration.
- Expanded organizational focus on outcomes, customer service, and family engagement.

- Implemented data-informed decision-making processes and enhanced quality assurance measures.

Clinical Director | May 2008 – July 2016

Provided clinical leadership and oversight for all therapeutic services, treatment planning, and clinical staff development.

Key Responsibilities:

- Directed clinical operations and treatment delivery across the program.
- Supervised, trained, and mentored therapists and clinical staff.
- Developed treatment protocols, clinical programming, and therapeutic interventions.
- Conducted admissions reviews and clinical appropriateness assessments.
- Facilitated individual, family, and group therapy.
- Collaborated with multidisciplinary teams to ensure integrated treatment planning.
- Supported crisis intervention and complex case consultation.
- Established standards for clinical documentation, utilization review, and treatment outcomes.

Accomplishments:

- Played a key role in expanding and refining Telos' clinical model.
- Developed therapist training systems and clinical supervision practices.
- Helped establish a culture of accountability and clinical excellence.

Primary Therapist | April 2006 – May 2008

Provided direct clinical services to adolescents and families within a residential treatment setting.

Key Responsibilities:

- Managed a caseload of adolescent clients and families.
- Conducted individual, family, and group therapy.
- Developed individualized treatment plans and clinical interventions.
- Coordinated multidisciplinary treatment teams.
- Conducted utilization reviews and insurance communication.
- Managed case coordination and discharge planning.

Heritage Schools | Utah

Residential Counselor / Residential Staff | May 2000 – April 2006

Provided direct care, supervision, mentoring, and behavioral intervention for adolescents in a residential treatment setting.

Key Responsibilities:

- Supervised student safety and daily functioning.
- Implemented behavioral and treatment plans.
- Supported emotional and behavioral stabilization.
- Facilitated skill development and therapeutic interventions.
- Collaborated with clinical and residential teams to promote treatment progress.

EDUCATION

Master of Social Work (MSW) / University of Utah 2006

Bachelor of Science in Behavioral Science / Utah Valley University 2004

Diploma in Health and Social Care / North Lindsey College United Kingdom 1998

PUBLICATIONS

Therapy: A Lifechanger, A Lifestyle, or a Waste of Time / Author, 2025

Consequential Choices: 10 Questions You Must Ask When Exploring Residential Treatment / Author, 2019

PROFESSIONAL PRESENTATIONS / National Association of Therapeutic Boarding Schools (NATSAP)

Selected Presenter:

• 2009 • 2015 • 2017 • 2020 • 2021 • 2025

Presented on topics related to adolescent treatment, family systems, therapeutic programming, organizational leadership, and residential care best practices.

HONORS & RECOGNITION

Leadership Award / Telos, 2022

Spirit of Telos Award / Telos, 2009

Clinical Excellence Award / Telos, 2007

AREAS OF EXPERTISE

- Executive Leadership
- Residential Treatment Programs
- Adolescent Mental Health
- Clinical Operations
- Family Systems Therapy
- Strategic Planning
- Organizational Development
- Staff Training & Supervision
- Crisis Management
- Risk Management
- Program Development
- Quality Assurance
- Budget Management
- Team Building
- Customer Service Excellence
- Admissions & Enrollment Strategy
- Therapeutic Program Design
- Change Management
- Leadership Development



Drew Davis, MSW, LCSW

Clinical Director, Telos Academy

Drew Davis, MSW, LCSW, is the Clinical Director of Telos Academy, a residential treatment center serving adolescent boys with emotional, behavioral, and mental health challenges. Since joining Telos in 2014, Drew has been dedicated to helping adolescents and families navigate complex mental health concerns through evidence-based treatment, meaningful therapeutic relationships, and a commitment to clinical excellence. He has served as Clinical Director since 2021, leading the clinical vision, therapist development, program innovation, and quality improvement initiatives across the organization.

Drew specializes in the treatment of adolescents experiencing depression, anxiety, trauma, substance use disorders, ADHD, emotional dysregulation, learning and processing challenges, and family relationship difficulties. His clinical expertise includes Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Dialectical Behavior Therapy (DBT), Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Exposure and Response Prevention (ERP), Neurofeedback, Play Therapy, and Motivational Interviewing.

Prior to Telos, Drew worked as an outpatient therapist at The Green House Center for Growth and Learning, providing therapy to children, adolescents, and families involved in foster care, adoption, state custody, and high-trauma environments. This work strengthened his foundation in attachment-based treatment, trauma-informed care, and family systems work. At The Green House, he maintained a high-volume clinical caseload, facilitated DBT groups, and received advanced training in EMDR, Neurofeedback, and Attachment Theory.

Throughout his career at Telos, Drew has played a pivotal role in the development and implementation of innovative treatment programs designed to meet the diverse needs of adolescents and their families. He was instrumental in the creation of The Carter House, a specialized treatment milieu for adolescents struggling with substance use disorders, and Harbor House, a lower-stimulation therapeutic environment designed to support students who experience heightened distress in larger group settings and benefit from reduced-stimulus clinical programming.

As Clinical Director, Drew has focused extensively on building a culture of clinical excellence through therapist training, clinical supervision, program development, and outcomes-informed care. His leadership emphasizes the integration of evidence-based practices, relationship-centered treatment, family involvement, and continuous professional development among clinicians. He is passionate about creating environments where both adolescents and clinicians can thrive.

Drew earned his Master of Social Work degree from Brigham Young University and is a Licensed Clinical Social Worker.

Professional Experience

Clinical Director, LCSW

Telos Residential Treatment Center – Orem, Utah | 2021 – Present

- Provides clinical leadership and oversight for all residential treatment programming
- Facilitates daily multidisciplinary treatment team meetings serving up to 54 adolescent clients
- Supervises clinical staff, therapists, and under-licensed clinicians
- Develops and delivers ongoing clinical training and supervision focused on clinical excellence
- Leads program innovation, including Telos Neuro Health, Carter House (substance use treatment), Geneva Campus (behavioral intervention), and Vineyard Campus (stabilization services)
- Collaborates with families and stakeholders to address complex clinical and systems-level needs.

Therapist, LCSW

Telos Residential Treatment Center – Orem, Utah | 2014–2021

- Maintained a caseload of 6–10 adolescents in residential treatment
- Provided 1.5 hours of individual therapy and 1.5 hours of family therapy weekly per client
- Facilitated therapeutic groups focused on emotional safety and self-esteem
- Trained residential staff on clinical interventions and treatment protocols
- Collaborated with multidisciplinary teams to support individualized treatment planning

Therapist, CSW

The Green House Center for Growth and Learning – Pleasant Grove, Utah

- Provided outpatient therapy services for children, adolescents, and families (caseload: 27–32 clinical hours weekly)
- Worked extensively with youth in foster care, adoption, state custody, and high-trauma environments
- Provided individual, family, and play therapy services for ages 2–18
- Facilitated DBT groups
- Received advanced training in EMDR, Neurofeedback, and Attachment Theory

Education

Master of Social Work (MSW)

Brigham Young University

Publications & Scholarly Contributions

Contributing Author, Chapter 10

Family Therapy with Adolescents in Residential Treatment: Intervention and Research (Springer, 2017)

- Assisted in writing Chapter 10 focused on family therapy interventions in residential treatment settings

Contributing Author, Chapter 4: “Bullycide and Evidence-Based Practice”

Hope 4 Utah: A Teacher's Guide to Suicide Prevention (2013)

- Assisted in writing Chapter 4 addressing bullying, suicide risk, and evidence-based prevention strategies

Professional Presentations & Training

- Facilitator, Annual Family Therapy Workshops for clinicians, parents, and treatment professionals
- Developer and presenter of weekly Clinical Excellence trainings focused on therapist development, evidence-based practice, and clinical skill advancement
- CEU Presenter, State of Utah – Presentation on Personalized Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (PrTMS) in mental health treatment
- Guest Lecturer, Weber State University Social Work Program – Presented on adolescent mental health, residential treatment, and clinical practice
- Ongoing trainer and supervisor for clinical staff and residential teams in trauma-informed care, family systems, and evidence-based interventions

Professional Recognition

- Clinician of the Year, Telos Academy (2019)
- Clinician of the Year, Telos Academy (2020)
- Spirit of Telos Award (2023) – Highest organizational honor recognizing exceptional leadership, service, and embodiment of organizational mission and values
- Leader of the Year, Telos Academy (2024)

Areas of Expertise

- Adolescent Mental Health Treatment
- Residential Treatment
- Trauma-Informed Care
- Family Systems Therapy
- Substance Use Treatment
- Clinical Leadership and Program Development
- Therapist Training and Supervision
- Evidence-Based Clinical Practice
- EMDR
- DBT
- CBT
- PrTMS
- Exposure and Response Prevention (ERP)
- Neurofeedback
- Motivational Interviewing
- Play Therapy



Toshiaki Sasao, Ph.D.

APA Membership

Category/Status:

Student Associate (1978-1988)

Member - elected (1989-2006)

Fellow - elected (Div. 27, 45, 52: 2007-present)

Education:

Post-doctoral
(2003-04)

University of Illinois at Chicago

Department of Psychology

NIMH Training Program in Urban Children's Mental Health & HIV Prevention

Post-doctoral
(1988-89)

University of California, Los Angeles, California

Department of Psychology and Asian American Studies Center

Ph.D.

(1981-88)

University of Southern California

Department of Psychology

Major: Social Psychology

Minor: Quantitative Psychology

(1983-86)

University of Southern California School of Medicine

Department of Preventive Medicine

Major: Applied Biostatistics

Minor: Preventive Medicine & Epidemiological Methods

M.Ed.

(1981)

University of Washington, Seattle

Department of Educational Psychology

Major: Educational Psychology (Psychometrics)

Minor: Program Evaluation

B.S. *magna cum laude*

(1979)

University of Washington, Seattle

Department of Psychology

Major: Psychology (Social and Clinical Emphasis)

Current and Past Professional Positions Held (*=concurrent):

04/26 – present

Professor Emeritus, International Christian University, Mitaka, Japan

04/26 – present

Visiting Research Scientist (Psychology), DePaul University, Chicago, U.S.A.

04/21 – 03/26

University Tokunin Professor, International Christian University, Mitaka, Japan

09/23 – 03/24

Distinguished Visiting Professor*, Institute of Psychology, Universitas Indonesia, Jakarta (Depok City), Faculty of Psychology, Indonesia

04/19 – 03/21

Department Chair, Department of Education & Language Education, International Christian University, Mitaka, Japan

04/97 – 03/21

Assistant Professor (4/97-3/99) → Associate Professor(4/99-3/04), → Professor of Psychology (4/04-3/21) (tenured), Department of Psychology, Division of Education and Graduate School of Arts and Sciences, International Christian University, Mitaka, Tokyo, Japan

04/22 – 03/24	<u>Adjunct Professor*</u> , School of Law (English Language Division), Meiji University, Tokyo, Japan
04/17 – 03/26	<u>Adjunct Professor*</u> , School of Global & International Studies (Psychology), Hosei University, Tokyo, Japan
03/99 – 03/26	<u>Adjunct Graduate Professor*</u> , Department of Psychology, Chuo University Graduate School, Hachioji, Japan
04/16 – 03/21	<u>Director*</u> , Peace Research Institute, International Christian University, Mitaka, Tokyo, Japan
04/12 – 03/16	<u>Interdisciplinary Major Coordinator*</u> , Peace Studies Program, International Christian University, Mitaka, Tokyo, Japan
04/02 – 03/26	<u>Coordinator*</u> , International Christian University – Community Research & Action Group (ICU-CRAG), Department of Psychology, Graduate School of Arts and Sciences, International Christian University, Tokyo
12/16 – present	<u>Salzburg Global Fellow*</u> , Salzburg Global Seminar, Austria
04/15 – 3/19	<u>Senior Fellow*</u> , University of Tsukuba, Graduate School of Global Japanese Studies
10/10 – 6/16	<u>Distinguished Visiting Professor Appointed by Rector*</u> , Institute of Psychology, University of Opole, Opole, Republic of Poland
01/09 – 03/09	<u>Visiting Professor*</u> , Department of Psychology, University of South Carolina, Columbia, South Carolina
08/07 – 06/09	<u>Research Professor*</u> , Institute for Research on Race and Ethnicity, College of Urban Planning and Public Affairs, University of Illinois at Chicago, Illinois, U.S.A.
06/07 – 08/12	<u>International Summer School Faculty (2-month in summer)*</u> , Yonsei University Underwood College, Sinchon, South Korea
04/99 – 03/07	<u>Adjunct Graduate Professor in Social Psychology*</u> , Department of Social Psychology, University of Tokyo - Graduate School of Humanities and Sociology, Tokyo, Japan
04/05 – 06/06	<u>Program Head*</u> , Graduate Program in Psychology, Department of Psychology, International Christian University, Mitaka, Tokyo, Japan
03/04 – 06/04	<u>Adjunct Professor of Psychology*</u> , Department of Psychology, DePaul University, Chicago, Illinois, USA
08/03 – 08/04	<u>Visiting Professor of Psychology*</u> , Department of Psychology, University of Illinois at Chicago, Chicago, Illinois, USA
04/01 – 03/06	<u>Program Director*</u> , American Studies Program, College of Liberal Arts, International Christian University, Tokyo, Japan
04/02 – 03/02	<u>Adjunct Graduate Faculty*</u> , Department of Social Behavior & Mental Health, Ochanomizu Women's University, Tokyo, Japan
09/00 – 08/03	<u>Evaluation Consultant*</u> , IBM – Tokyo, Japan
09/00 – 03/01	<u>Assistant Director*</u> , American Studies Program, College of Liberal Arts, International Christian University, Tokyo, Japan
04/99 – 03/01	<u>Director*</u> , Office of Faculty Development, College of Liberal Arts, International Christian University, Tokyo, Japan
06/99 – 12/00	<u>Director of Research*</u> , Illegal Drug Market Research, United Nations University, Tokyo.
10/96 – 03/97	<u>Associate Professor of Research in Psychiatry & Human Behavior</u> , Department of Psychiatry and Human Behavior, College of Medicine, University of California, Irvine, CA
10/94 – 03/97	<u>Principal Investigator/Project Director (NIDA)*</u> , Alcohol, Tobacco & Other

	Drug Use among California's Asian Adolescents, WestEd, Los Alamitos, California
05/88 – 10/96	<u>Assistant → Associate Research Professor of Psychology (Levels I ~ IV),</u> Department of Psychology, UCLA
01/90 - 10/96	<u>Project Director,</u> Asian American Prevention Project, Department of Psychology
10/94 - 10/96	<u>Project Director,</u> Statewide Asian Drug Prevention Evaluation Project, UCLA Drug Abuse Research Center, Neuropsychiatric Institute, UCLA
06/92 - 05/96	<u>Principal Investigator/Project Director,</u> Korean American Health Project, National Research Center on Asian American Mental Health, Department of Psychology, UCLA
10/91 - 10/96	<u>Principal Evaluator,</u> Comprehensive Asian Youth Substance Abuse Project, Asian Pacific Family Center, Rosemead
10/89 - 09/94	<u>Principal Evaluator,</u> Asian Pacific Youth Project, Asian American Drug Abuse Program, Los Angeles
01/90 - 10/91	<u>Principal Investigator/Project Director,</u> Statewide Asian Drug Service Needs Assessment, Department of Psychology, UCLA
07/89 - 10/89	<u>Research Psychologist/Statistician,</u> Neuropsychiatric Institute, University of California, Los Angeles
05/88 - 09/89	<u>Postdoctoral Research Fellow,</u> Department of Psychology and Asian American Studies Center, University of California, Los Angeles
08/95 - 05/96	<u>Visiting Associate Professor of Behavioral Science*,</u> Graduate School of Behavioral Science, California State University at Dominguez Hills, Carson, CA.
06/93 - 08/94	<u>Lecturer*,</u> Department of Psychology, UCLA
08/88 - 05/89	<u>Assistant Professor of Psychology,</u> Department of Psychology, Division of Social/Behavioral Sciences, Marymount Palos Verdes College, Rancho Palos Verdes, California
02/88 - 06/88	<u>Visiting Assistant Professor of Psychology*,</u> Rosemead School of Psychology, Biola University, La Mirada, CA
01/87 - 05/88	<u>Biostatistical Consultant*,</u> Division of Biometry, Department of Preventive Medicine, University of Southern California School of Medicine
09/83 - 06/84	
05/85 - 05/87	<u>Research Psychologist/Psychometrician*,</u> Institute for Prevention Research, Department of Preventive Medicine, University of Southern California School of Medicine
09/84 - 06/85	<u>Research Assistant*,</u> Department of Psychology & Social Science Research Institute, University of Southern California
09/82 - 12/84	<u>Teaching Assistant*,</u> Department of Psychology, University of Southern California
12/78 - 01/81	<u>Mathematics & Statistics Instructor*,</u> Instructional Center, Office of Minority Affairs, University of Washington, Seattle
09/78 - 01/79	<u>Teaching Assistant*,</u> Learning Disabilities Program, Experimental Education Unit, Child Development & Mental Retardation Center, University of Washington, Seattle
06/78 - 03/79	<u>Research Assistant*,</u> Department of Psychology, University of Washington, Seattle

神經多樣性的概念與演化

Neurodiversity - An Evolution of the Concept

亞東紀念醫院兒少神經多樣性共照中心主任
台灣青少年神經多樣性行動協會理事長
美國哈佛麻州總醫院神經部研究員
國立陽明交通大學臨床副教授

甄瑞興醫師

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

1

前言

- 這個「**神經多樣性**」一詞最早於1998年由美國記者**哈維·布盧姆**（Harvey Blume）在一篇文章中提出，用來描述人類神經表達的自然多樣性，為「神經學的多樣性」（neurological diversity）的混成詞。
- 布盧姆是神經多樣性運動的早期倡導者之一，他在1997年6月30日的《紐約時報》文章中，用「神經多元」（neurological pluralism）一詞來描述神經多樣性的基礎。
- 同年，該詞也出現在澳大利亞社會學家**朱迪·辛格**（Judy Singer）的社會學榮譽論文中，以促進「神經少數群體」的平等和包容。辛格自稱自己「很可能屬於自閉症譜系」。
- 過去20多年，他們期待不再將神經多樣性人們這些差異視為問題，而是將它們視為人類多樣性的特質及表現。

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

2

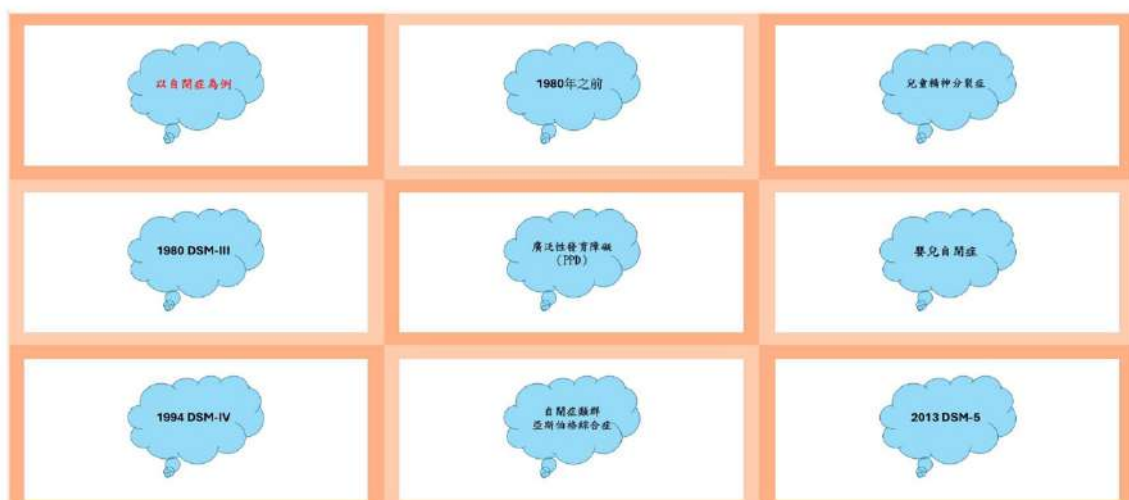
前言

- 「神經多樣性」個體是指一些其大腦功能與典型標準大腦功能的人有所不同的人
- 他們在資訊處理、學習過程或行為方式都跟別人不太一樣
- 神經多樣性不是一個醫學診斷，而是一個比較平等、包容及多樣性的稱謂。
- 例如失智症候群（Dementia syndrome）是失智症的大雨傘而非一個明確診斷，再下來阿茲海默症（Alzheimer's disease）、血管性失智症、路易氏體失智症等才是真正的臨床診斷。
- 所以神經多樣性（Neurodiversity）也只是一個總稱，而非一個明確診斷，再下來自閉症類群障礙（ASD）、注意力缺陷過動障礙（ADHD）、閱讀障礙等才是真正的臨床診斷。

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

3

以自閉症為例



台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

4

以自閉症為例



台灣兒童青少年神經多樣性行動協會 蔡瑞興

台灣青少年神經多樣性行動協會 蔡瑞興

5

自閉症的故事

- 兒童**精神分裂症**，1980年之前，
- 廣泛性發育障礙（PPD），1980 DSM-III
- 嬰兒自閉症，1980 DSM-III
- 自閉症類群（Autism spectrum），亞斯伯格綜合症，1994 DSM-IV
- 自閉症類群障礙（ASD），2013 DSM-5
- **神經多樣性**，20世紀末

台灣青少年神經多樣性行動協會 蔡瑞興

6

一個青少年小洋的自白

- 我不知道我需要交朋友
- 我真的相信我不需要其他人
- 我不知道如何接近其他人或跟他們講話
- 我不關心學習，因為大多數互動都會讓我感到煩躁和被忽視
- 我缺乏對不合理的要求說“不”的能力
- 但我的成績很好，我的聰明才智為我贏得了很多讚揚
- 我不喜歡改變
- 我對食物的質地和濃郁的味道感到困惑
- 我很容易被突然的變化造成不知所措

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

7

小洋的自白

- 自閉症是一種可恥的、維持生命的疾病稱號
- 自閉症的稱謂快讓我崩潰
- 我常常只想戴著笨重的大耳機去超市，我總是被嘈雜的聲音和明亮的燈光所淹沒
- 當我壓力太大時便會出現悲傷的感覺
- 我把這一切隱藏了很多年，因為我確信這已經讓我成為一個無趣、不可愛的混蛋。
- 隨著我的長大，我學會了不那麼緊張、不那麼尷尬，少一些自我，我不希望我會像他們一樣出現自殘、抽煙和酗酒……



台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

8

- 全世界有神經多樣性的確切人數尚不清楚
- 據統計地球上大約五分之一的人具有神經多樣性
- 15-20% 的人有潛在的神經多樣性的特質
- 3.2% 的 8 歲兒童患有自閉症類群障礙。
- 男孩/女孩：3.4/1（根據美國疾病預防控制中心資料）
- 11.4% 的兒童在 18 歲之前被診斷出患有過動症。（根據美國疾病預防控制中心的說法）
- 20% 的人口患有閱讀障礙（根據美國耶魯大學中心的數據）

9

[illegible]

10

神經多樣性的歷史

- 世界上有兩類人群：神經典型人群和神經多樣性人群
- 神經多樣性的人是指他們的大腦在處理、學習和/或行為上與被認為是“典型”的人不一樣
- 神經多樣性的人包括自閉症患者、過動症、閱讀障礙者、運動障礙者、聯覺者、閱讀過度者、計算障礙者以及那些認知有差異的人
- 並非所有神經多樣性的表現都是有病的，在他們尚未有其他共症時，只是他們有他們的大腦有不同的表現方式而已。
- 因此現在部分人期待不再將有神經多樣性特質而尚未有共症的人，視為一個病人
- 神經多樣性的表現方式有很多種，從大多數人永遠不會注意到的非常溫和的行為，到嚴重社會脫節的行為都有可能

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

11

神經典型人群

- 神經典型的人群是指他們大腦在功能、行為和處理上都被認為是標準或典型範圍內的人
- 神經正常的人可能不知道自己是神經典型的
- 這些人通常在大多數人的眼中，認為是在標準的時程和年齡內達到了一般發育和行為的里程碑
- 一但長大後，他們通常會在正常生活中生活，而不必懷疑他們的大腦的運作方式是否與其他人不一樣

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

12

兒少情緒障礙 民間籲正名神經多樣性



- 神經多樣性是一個概念一個稱謂
- 即某些人們的大腦有多種方式處理信息、功能和行為的能力，可呈現多種多樣的思考方式，我們不見得把它認為有問題或沒有問題
- 神經多樣性在概念上，也試圖將這些與別人的差異視為個人本質，並無好壞的問題
- 反之，我們以中肯的方法去看它，並強調神經多樣性的人有許多不同的思考方式，**不見得**不是一件好事。



神經多樣性 Neurodiversity

- 神經多樣性的人對世界的看法與神經典型的同齡人不同，這是沒有錯的，因為世界上**每一個人均有不同**的想法
- 他們常會有獨特而細緻的考慮方式，對事情持有不同的假設，用創新的模式和框架來看待問題，並最終提供不同的解決方案
- 神經多樣性代表了一種不同的思維方式，與眾不同及有內在價值的意思
- 通常我們可以在神經多樣性人群中找到一些未來的技能，例如：**橫向思維、系統思維、視覺空間思維、創造力和高度專注能力**，故神經多樣性青少年可能比神經典型青少年面臨更多生活上的挑戰
- 假如我們認為神經多樣性青少年是問題青少年的話，我們會傷害到不少神經多樣性的青少年及其家庭的心

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

15

神經多樣性 Neurodiversity

- 神經多樣性是一種**發育障礙**，會影響他們體驗周圍世界的方式
- 神經多樣性人們在這個世界上佔不少數
- 神經多樣性的個性一直存在，他們一輩子都會有神經多樣性特質
- 有些神經多樣性者也有智力障礙，有些人在日常生活中需要很多協助，而有些神經多樣性者只需要一點點的幫忙，甚至能力超越常人
- 我們對每位神經多樣性的人都有**不同的經驗**。



台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

16

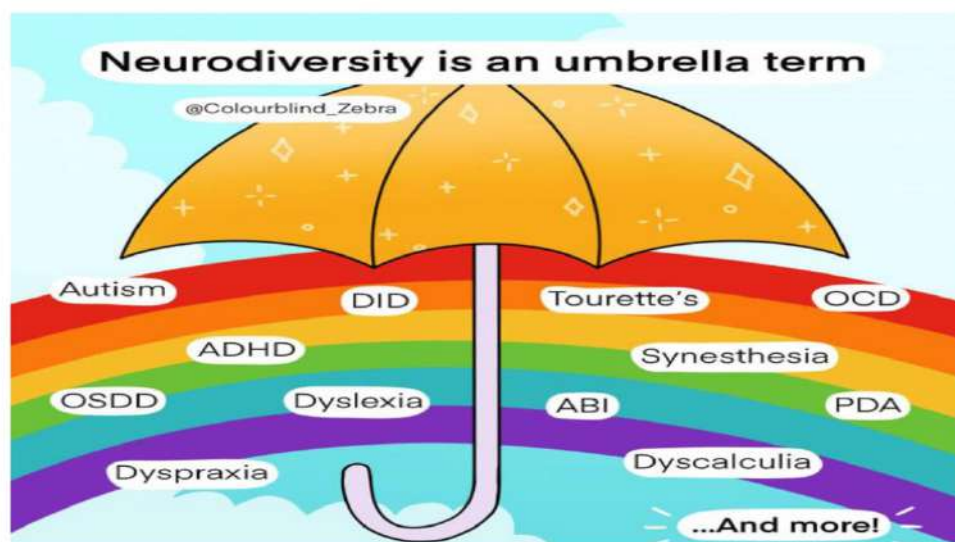
神經多樣性的不同

- 以不同的方式思考
- 不同的感知過程
- 以不同方式的行動
- 以不同方式的溝通
- 以不同的社交方式
- 可能需要日常生活方面的幫忙

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

17

神經多樣性是一個總稱



台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

18

神經多樣性的類型

1. 自閉症類群障礙
2. 注意力缺陷過動障礙 (ADHD)
3. 閱讀障礙
4. 抽動穢語綜合症
5. 唐氏綜合症
6. 運動障礙
7. 聯覺
8. 計算障礙
9. 癲癇
10. 雙相情感障礙
11. 邊緣性人格障礙
12. 強迫症
13. 焦慮

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

19

神經多樣性的十大警訊

1. **執行功能困難**：在日常生活活動的規劃、組織、起動、轉換或估計時間時遇到困難。（例如，想開始卻拖延，途中卻忘了進度。）
2. **注意力調節問題**：容易分心或長時間專注於單一興趣。（這在注意力不足過動症、自閉症、閱讀障礙中很常見。）
3. **工作記憶問題**：經常忘記指令、經常遺失物品，或需要反覆提醒。
4. **社交溝通困難**：難以理解社交暗示、難以字面理解語言，比較喜歡書面溝通，或難以應付瑣碎的寒暄。
5. **感官敏感**：對聲音、光線、質感、氣味或觸感反應過度或不足。（例如，某些聲音讓他難以忍受；衣服標籤的刺激做成不舒適感）

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

20

神經多樣性的十大警訊

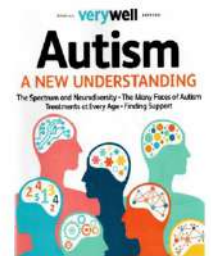
6. **情緒調節挑戰**: 突然強烈的情緒反應及轉變困難，或是在輕微壓力後出現「崩潰」的現象。
7. **僵硬頑固或過度專注的思維模式**: 強烈偏好固定習慣、深度投入某些特別興趣，或難以轉換思維。
8. **語言或學習困難**: 閱讀困難（閱讀障礙）、寫作困難（書寫障礙）或數學障礙（數學障礙）。（例如，閱讀速度緩慢、字母反轉、數學事實記憶困難。）
9. **運動協調困難**: 動作不靈活、精細動作能力差，或是綁鞋帶等任務困難（動作協調障礙、攀爬、跑步等）。
10. **重複行為或思考模式**: 重複動作、重覆每日的老習慣，或重複唐突擾人的侵入性思維（常見於自閉症、強迫症、妥瑞氏症）。

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

21

1. 自閉症類群障礙 (Autism Spectrum Disorder)

- 自閉症是一系列廣泛的疾病，
- 可能會出現社交技能方面的問題、重複行為和言語困難，這些困難可能導致他們用其他替代方式進行交流，這些方法包括書寫、打字或手語。
- 自閉症患者通常以一種固定的模式去思考、去處理他們的感官、行動、交流和社交，這些方式常與其他的人不一樣。



台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

22

自閉症類群障礙

- 據估計，26.7% 的自閉症譜系患者患有嚴重的障礙，以至於他們需要 24 小時護理。
- 有些人是語言障礙的、大小便失禁的、自我虐待的，甚至具有攻擊性的
- 大多數人都有嚴重的感官問題，造成社交活動感到身體痛苦。
- 有些人患有相關的身體和情緒問題，例如焦慮、抑鬱、癲癇、睡眠障礙和胃腸道疾病。
- 對於這個龐大的群體來說，需要社會大眾的接受和支持，才足以讓他們有安全及平穩的生活。

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

23

自閉症類群障礙程度差異

- 自閉症患者可以健談或不會說話，聰明或認知障礙
- 他們可能對聲音和光線過敏拒絕，但有些人又可以對樂隊中演奏打擊樂，感到自在，甚至成為鼓手、音樂家。
- 自閉症兒童可能有嚴重的行為問題，或者他們可能異常安靜和反應遲鈍
- 有些自閉症患者擁有非凡的能力，他們可以完成其他人則難以完成的活動、行為。
- 在一個診斷類別中，有不同的症狀、個人素質、能力和殘疾程度等，因人而異。
- 對於一些自閉症患者來說，差異可能不會對患者本身造成任何痛苦。相反，苦難可能是社會人士的眼光和不平等的對待而導致。

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

24

自閉症類群障礙 (Autism Spectrum Disorder)

- 他們說“當你遇到一個自閉症患者時，你就遇到了一個自閉症患者。”
- 每個自閉症患者都有不同的優勢和需求。
- 所以對於如何支持自閉症患者沒有單一的“正確”答案，但有很多很好不同的正面方向。

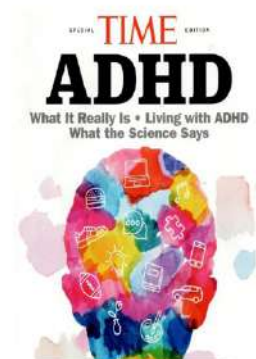


台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

25

2. 注意力缺陷過動障礙 (ADHD)

- 是一種執行功能失調障礙，這意味著個人可能難以管理自己的思想、注意力、行為和情緒。
- 患有多動症的人可能難以組織、焦躁不安、顯得不感興趣或分心，並在經歷強烈情緒時，會表現出不當的行為。
- 通常有衝動、過動或注意力不足三種不同的情形出現



台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

26

a. 注意力不足

1. 經常無法仔細注意細節或者在做學校功課、工作或其他活動時，容易操心犯錯
2. 工作或上課、長時間閱讀、遊戲時難以維持持續注意及專注力
3. 直接對話時，常好像沒有在聽，心好像在別處
4. 經常無法遵循指示，而無法完成學校功課或工作場所的責任
5. 難以維持有序的擺放物品，亂七八糟、時間管理不良，無法準時交件
6. 經常逃避、不喜歡、或不願意從事需要持久心力的工作
7. 經常遺失筆、書、工具、錢包、鑰匙、書寫作業、眼鏡、手機等
8. 經常容易受到外在刺激而分心
9. 在日常生活中常忘東忘西

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

27

b. 過動

- 經常手腳不停的動或輕敲/踏，或者在座位上蠕動
- 經常在該安坐時，突然離席離開他的位置
- 經常在不宜跑或爬的場所起來跑或爬
- 經常無法安靜地玩或從事一般休閒活動
- 經常處在活躍的狀態，好像被人趕著要跑般的行動
- 無法在餐廳、會議中長時間安坐，別人會感覺到他坐立不安

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

28

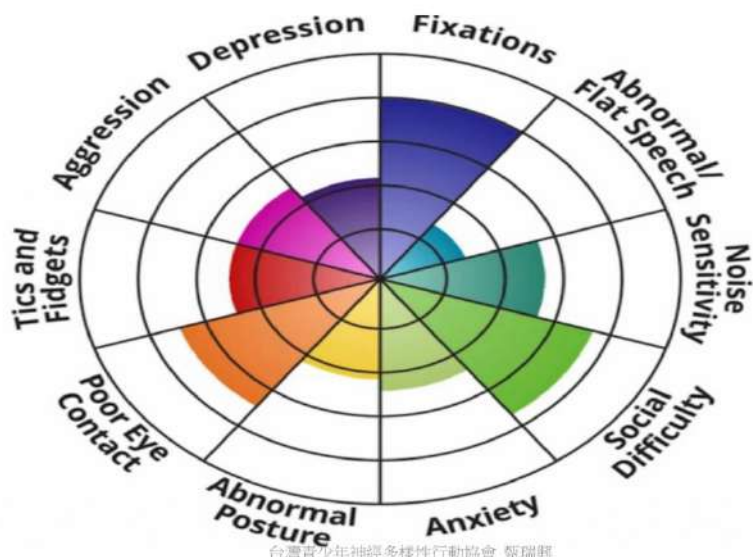
C. 衝動

- 經常因衝動在別人問題尚未講完時沖口而出，說出答案
- 經常因衝動難以等待排序或排隊
- 經常因衝動而打斷或侵擾他人進行中的活動，在遊戲或活動時貿然介入

3. 閱讀障礙

- 閱讀障礙者通常與閱讀、寫作或說出無序的單詞或字母有關，但它包含的遠不止於此。
- 它可能涉及與某些字母的混淆、難以將單詞組織成句子、難以獲取詞彙或發音單詞，和/或難以遵循指示。
- 患有閱讀障礙的人通常是**大局觀**思考者，擅長**視覺**處理。此外，他們往往具有很強的**空間意識**，並且可能**非常有創造力**。

神經多樣性的人的共症



31

你有神經多樣性嗎？

- 一般的神經多樣性是因先天大腦發育和功能不足而形組成的
- 雖然神經多樣性很常見，但許多人直到成年才意識到自己是神經多樣性
- 雖然這些差異在童年時期可能未被識別或診斷出來，但這並不意味著它們不存在，常常在成年後突然被發現了。
- 後天性神經系統疾病，例如創傷性腦損傷、腦中風和阿爾茨海默病，也可能導致神經多樣性

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

32

考慮如何適當的介入/療法

- 許多家庭為他們的孩子被診斷出患有神經多樣性，並立即開始尋求越來越多的方法來“根治”他們的孩子
- 兒童青少年神經多樣性的早期介入現在已被重視和肯定，同時在增加青少年與父母親溝通和社交支援互動都非常有效的
- 我們要一併發揮青少年的優勢和興趣，而不是要去想辦法“根治”他們



台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

33

我可以做些什麼？

- **聆聽**:神經多樣性的人可能會感到被誤解或被冷落。願意傾聽他們。讓他們知道您聽到了他們的聲音並尊重他們和他們的選擇。
- **以對他們有幫助的方式進行溝通**:有時，神經多樣性青少年更喜歡書面交流，例如簡訊或電子郵件，而不是電話或面對面交談。給他們溝通所需的時間和工具。
- **避免使用不必要的標籤**:不要使用「高功能」和「低功能」來描述他們。我們經常根據一個人的行為與神經典型者的程度來比較，是不好的
- **沒有兩個神經多樣性的人是相同的**:神經多樣性人群的性格和偏好可能大不相同，即使他們有相同的潛在狀況。
- **不要假設每位神經多樣性青少年都是無能或不聰明的**:其實神經多樣性的人通常具有使他們脫穎而出或顯得不同的一面
- **我們要尊重他們每一個人**

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

34

神經多樣性診斷與治療

1. 神經多樣性本身並非一個臨床診斷
2. 被診斷的是神經多樣性範疇下的特定神經發展狀況，例如自閉症、注意力缺陷過動症（ADHD）、閱讀障礙、動作協調障礙、感覺統合障礙、抽動障礙等。
3. 診斷需要結構化的臨床評估
4. 治療則是個別化的，結合行為治療、教育支持、環境調整，有時還會用藥

台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

35

神經多樣性診斷與治療

領域	內容	執行	工具/方法
評估	辨識臨床特徵	精神科、心理學專家為主 小兒神經科（ADHD）、家醫科醫生（校園評估）	Clancy、CAST、心理衡鑑等
診斷	完整臨床評估	精神科醫師、神經心理學專家	精神科醫師會談後綜合各項資訊診斷
行為治療	技巧、應對、溝通	職能治療師、語言治療師、心理治療師	CBT, OT, 社會技巧
藥物治療	症狀管理	精神科、小兒神經科（ADHD、妥瑞、癲癇等）神經科（妥瑞、癲癇等）	Stimulants, SSRIs, antipsychotics, anticonvulsants etc.
調適	環境支持	學校與照顧者	IEP, ADA accommodations
精準醫療	基因基礎介入	專家	Genomic testing

36

神經多樣性的著名和成功人士

- **Tesla 電動車執行長 馬斯克**
- 奧斯卡獲獎演員安東尼·霍普金斯爵士
- 音樂家兼歌手 Florence Welch
- 奧運金牌得主西蒙·拜爾斯
- 氣候活動家 Greta Thunberg
- 諾貝爾物理學獎得主和**化學家居里夫人**
- **諾貝爾獎得主理論物理學家阿爾伯特·愛因斯坦**
- 藝術家文森特·梵古
- 發明家兼工程師 Nikola Tesla
- 作者 F. Scott Fitzgerald



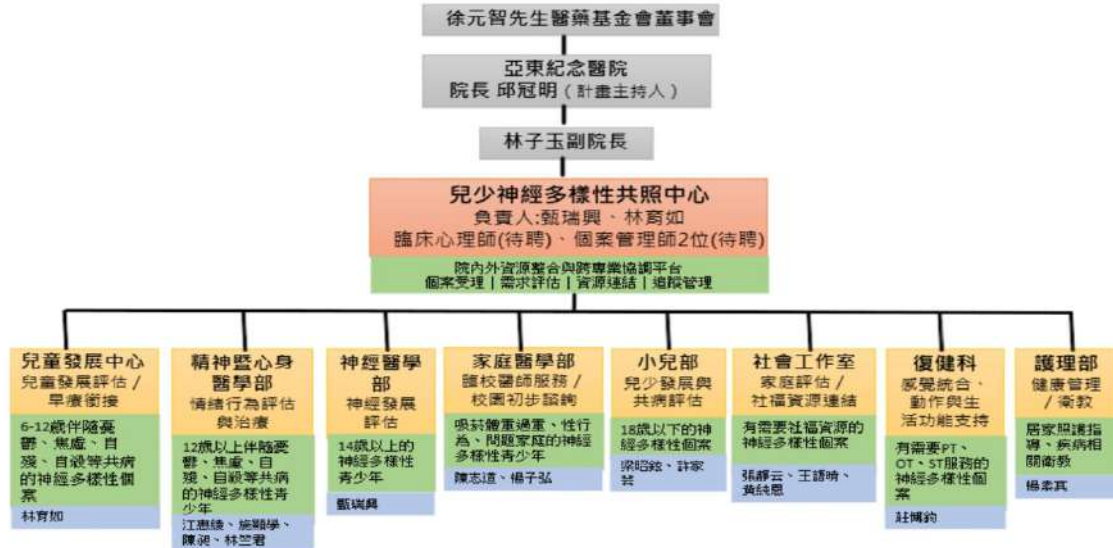
台灣青少年神經多樣性行動協會 甄瑞興

37

亞東醫院兒少神經多樣性共照中心成立

1. 建立新北市兒童青少年神經多樣性共照示範中心
2. 透過醫療端與校園端之合作，協助疑似自閉症類群障礙、注意力不足過動症、學習困難、情緒困擾或生活適應困難之兒少，及早進入評估與支持體系
3. 並依其需求**提供連續性追蹤、家庭諮詢與資源連結**，以促進兒少身心健康、學習適應、家庭韌性與社會參與

亞東醫院兒少神經多樣性共照中心



115年青少年神經多樣性生活陪跑師 基礎概念訓練課程

(115年9月14日起跑)

1. 以神經多樣性為核心理念：理解 ADHD、自閉症、讀寫障礙等不同大腦運作方式。
2. 強調個別化策略：不使用「一般人都適用」的技巧，而是依照個人認知模式調整。
3. 專注生活技能與執行功能：協助時間管理、組織能力、情緒調節、任務啟動等。
4. 支持自我認同與自我倡議：幫助個人理解自己的大腦、需求與優勢。

115年青少年神經多樣性生活陪跑師基礎概念訓練課程

日期：115年9月14日

時間：09:00-17:00

地點：亞東醫院會議室

時間	TOPIC / 演講主題	SPEAKER / 講師
08:00-08:10	Registration / 登記	
08:10-08:15	Opening remarks / 致詞	
08:15-08:50	A Brief on Neurodiversity in Asia (center) 亞洲青少年神經多樣性	謝淑卿主持 亞東紀念醫院兒少神經多樣性 服務中心主任
08:50-09:50	Introduction of Life Skills Coach 生活技能師導論	Berry Felt Trilan 亞東醫院特教中心
09:50-10:00	Coffee break / 休息時間	
10:00-11:00	Professional skills of Life Skills Coach 生活技能師專業技能	Drew Davis Trilan 亞東醫院特教中心
11:00-11:40	Understanding Neurodiversity: International legislation Difficulties and Coping Skills in Children and Adolescents 理解神經多樣性：國際立法與青少年困難與因應	林育如主持 亞東紀念醫院兒童發展中心
11:40-12:00	Panel Discussion 綜合討論	Berry Felt, Drew Davis 謝淑卿主持、林育如主持
12:00-13:00	Lunch / 午餐	
13:00-13:50	Understanding Neurodiversity: Global and Asia Attention, Impulsivity, and Inhibition 理解神經多樣性：全球與亞洲 注意力、衝動與抑制	謝淑卿主持 亞東紀念醫院兒童發展中心
13:50-14:50	De-escalation techniques 緩和衝突技巧	Dr. David Lee 亞東紀念醫院特教中心
14:50-15:40	Coffee break / 休息時間	
15:40-16:40	Effective Parenting 有效親育技巧	區寶嘉管理師
16:40-17:00	Panel Discussion 綜合討論	區寶嘉主持、林育如主持 謝淑卿主持、區寶嘉主持
17:00-17:40	Closing / 閉幕	

亞東醫院兒少神經多樣性共照中心目的及目標



Thank you for your attention

亞東紀念醫院兒少神經多樣性共照中心



理解家中神經多樣性兒童青少年

Understanding Children & Adolescents with Neurodiversity in home environment

亞東紀念醫院 Far Eastern Memorial Hospital
／台灣大學附設醫院 National Taiwan University Hospital

兒童發展中心 Child Development Center／精神暨心身醫學部
Psychiatry／兒童心理衛生中心 Child Mental Health Center

主任 Chief／精神科主治醫師 Psychiatrist
林育如 Yu-Ju Lin

2026.9.12

常見的四大類診斷族群

⚡ ADHD

注意力不足過動症

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

🌈 ASD

自閉症類群

Autism Spectrum Disorder

📖 學習障礙

閱讀、書寫、數學障礙

Learning Disabilities

💛 焦慮與情緒調節

焦慮與情緒調節困難

Anxiety & Emotional Dysregulation



HHS Public Access

Author manuscript

Cell. Author manuscript; available in PMC 2020 December 12.

Published in final edited form as:

Cell. 2019 December 12; 179(7): 1469–1482.e11. doi:10.1016/j.cell.2019.11.020.

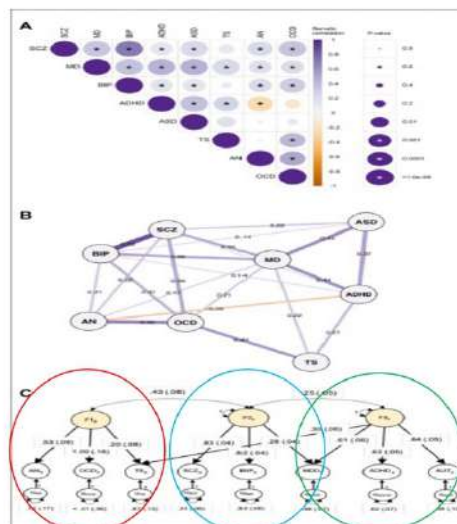
Genomic relationships, novel loci, and pleiotropic mechanisms across eight psychiatric disorders

Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium*

疾病對組合	遺傳相關係數 (rg)
SCZ-BD	~0.70
MDD-ADHD	~0.42
SCZ-ADHD	~0.18
OCD-AN	~0.50
ASD-ADHD	~0.36

Gene / Locus	Chromosome	Associated Disorders	Function
CACNA1C	12	SCZ, ADHD, BD	Calcium channel; synaptic plasticity
DRD2	11	SCZ, ADHD	Dopamine D2 receptor; psychosis & impulse
SLC6A3 (DAT1)	5	ADHD, SCZ	Dopamine transporter; DA reuptake
GRM3	7	SCZ, ADHD	Glutamate receptor; learning, memory
FOXP2	7	ADHD, SCZ, ASD	Language development; neuro-connectivity

各種神經發展狀態常常一起發生



第二章 CHAPTER 2

⚡ ADHD：注意力不足過動症

ADHD: Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder



ADHD 的三種樣貌

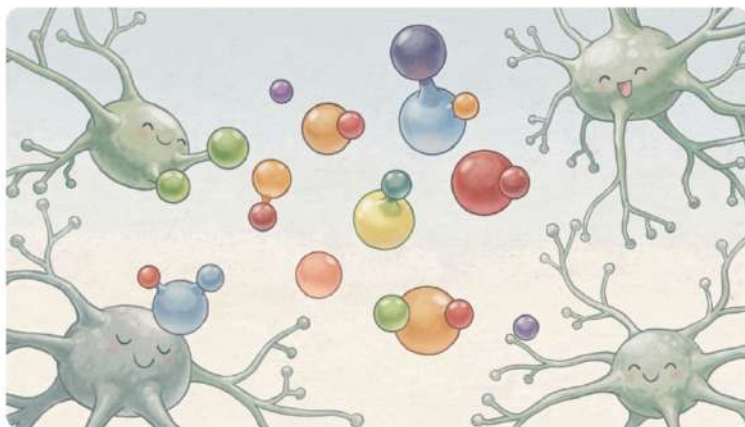
Three Presentations of ADHD



ADHD 盛行率 5-10%，有增加趨勢。我們小時候沒有 ADHD ？

神經傳導物質的角色

The Role of Neurotransmitters



多巴胺 Dopamine

動機、獎勵、注意力調節——ADHD 與 ASD 均受影響

Motivation, reward, attention — affected in both ADHD & ASD

血清素 Serotonin

情緒穩定、焦慮調節

Emotional stability and anxiety regulation

去甲腎上腺素 Norepinephrine

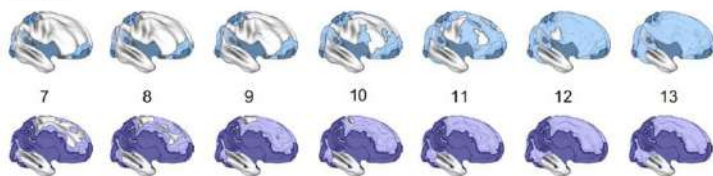
警覺性與專注力

Alertness and sustained focus

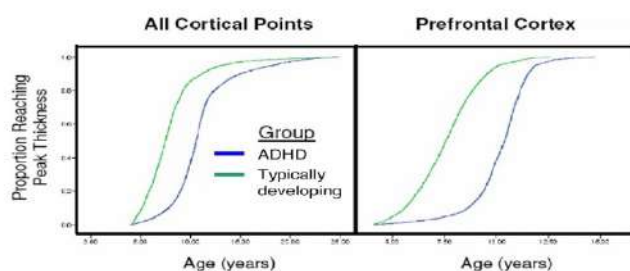
ADHD 的大腦機轉

腦部成熟較慢

ADHD



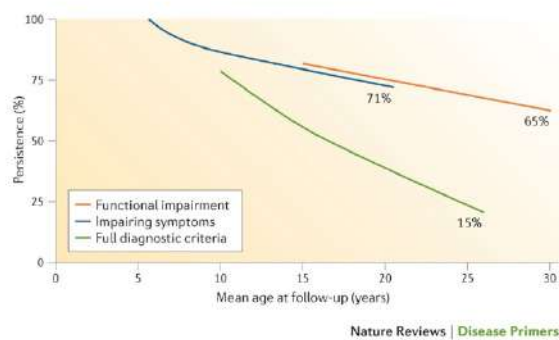
Typically developing controls



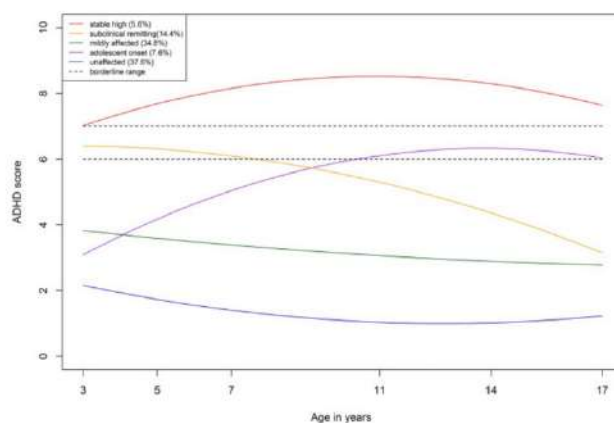
Source: Shaw et al, PNAS, 2007

ADHD 症狀隨著年齡增長會變好嗎？會痊癒嗎？

- 群體研究



Faraone, S. V. et al. (2015) Attention-deficit/hyperactivity disorder
Nat. Rev. Dis. Primers doi:10.1038/nrdp.2015.20



Carter L, Speyer L, Caye A, Rohde L, Murray AL. Late adolescent outcomes of different developmental trajectories of ADHD symptoms in a large longitudinal study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2025 Feb;34(2):709-719.

ADHD 執行功能缺損(executive function deficits)： 大腦的中央執行系統、記憶體缺損



工作記憶 **Working Memory**

短暫儲存並使用資訊的能力



彈性思考 **Cognitive Flexibility**

注意力切換 **Attentional Shift**

在不同任務或想法之間切換、注意力切換



抑制控制 **Inhibition**

暫停衝動、控制行為



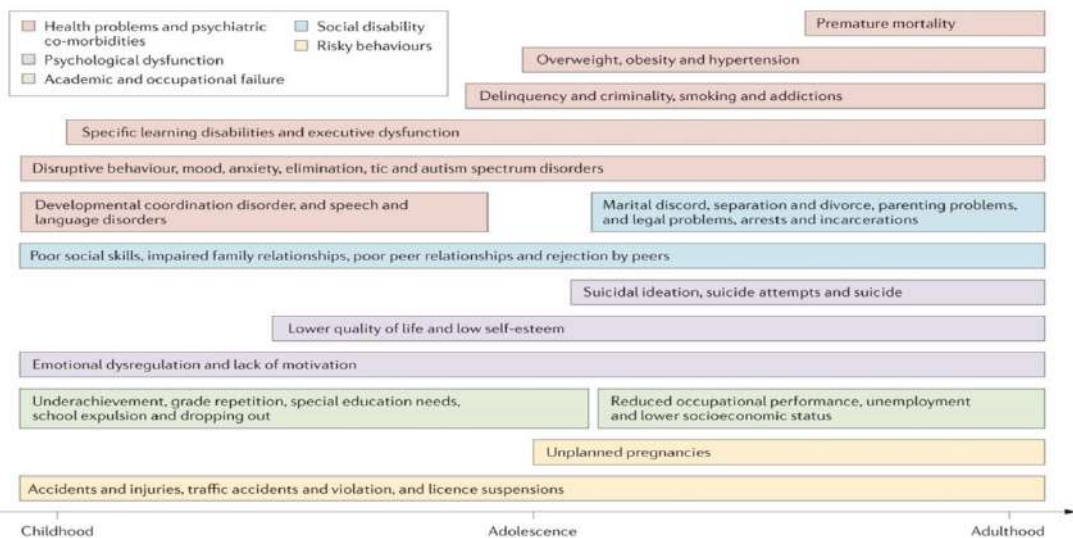
計畫組織 **Planning**

設定步驟、有序完成任務

- ☐ 神經多樣性孩子的執行功能發展較慢或功能不彰，但並非「不努力」

Slower or insufficient development – not laziness

症狀持續者 不同階段挑戰



Faraone, S. V. et al. (2015) Attention-deficit/hyperactivity disorder
Nat. Rev. Dis. Primers doi:10.1038/nrdp.2015.20

Nature Reviews | **Disease Primers**

怎麼理解 ADHD 孩子？ 是症狀還是個性？（一）

很多 ADHD 的行為，看起來像「個性問題」，其實背後都有神經科學的解釋。理解這些行為的根源，才能給予最有效的支持。

👤 動個不停、衝動、易怒、話多

額葉無法有效控制「想動的意念」——意念一出，動作隨即跟上，幾乎零時差。全身一定要有一個地方在動，連擺手、擺指甲也是同樣機制在作用。

🧒 沒事找事、搞笑、頻繁要求陪伴

ADHD 大腦對刺激的需求較高，酬償系統需要較強刺激，非常怕無聊。他們需要頻繁的外在回饋來抵抗無聊感，因此常出現吸引他人注意力、喜歡惡搞、不喜歡等待的行為。

😡 易怒、要就是要、無法延遲滿足

情緒啟動快、強度強，加上額葉欠缺自我抑制與調節能力，導致無法延遲滿足。這不是「任性」，而是大腦調節迴路發展尚未成熟的表現。

🗣️ 故意唱反調、激惹他人、不認錯

部分 ADHD 者同時伴有對立反抗症狀（ODD），表現為故意與大人作對、愛面子、難以承認錯誤，背後仍與情緒調節困難密切相關。



怎麼理解 ADHD 孩子？ 是症狀還是個性？（二）

除了外顯的活動量問題，ADHD 也常以「渙散、健忘、被動」的面貌出現——這些同樣不是態度問題，而是神經功能差異造成的結果。

叫他好像沒聽到



注意力警醒度不足，加上重要訊號的區辨能力較差——大腦無法自動將叫喚判定為需要立刻回應的訊號。

話聽一半、無法多工



工作記憶缺損使得同時處理多項資訊的能力受限。當新訊息進來，舊訊息往往就被擠出去——不是不想記，是記憶體容量的神經限制。

轉頭就忘、丟三落四



被內在意念或外在刺激一打斷，就忘記原本要做的事。額葉無法有效抑制雜訊，加上預設模式網路（DMN）與額葉互動異常，任務執行被打斷。



散漫、被動、沒有企圖心

酬償系統的多巴胺動力不足，導致對「一般事物」提不起勁。部分人則以相反方式呈現：癡狂追求高強度刺激（如電玩、極限運動）。



東西很亂、做事沒有章法

額葉執行功能與組織規劃能力較弱，難以自主建立系統性的做事順序，環境也因此容易顯得凌亂無序。

怎麼理解 ADHD ?

How to Understand ADHD at Home



實用支持方向

- 使用視覺化提醒工具（時間軸、圖卡）
- 將任務拆成小步驟，即時給予回饋
- 建立固定的環境結構與生活流程
- 以理解取代責備，以引導取代懲罰

但，支持不是無限上綱，須考量人力物力與其他許多現實因素 !!!!

行為背後是調節困難

孩子的「不聽話」背後是神經調節困難，而非故意挑釁
Defiance is often dysregulation, not deliberate

是一種生理困難，不是懶惰或是故意
意志力很難控制

是遺傳或天生的，不是教養造成
但不當教養會惡化情緒行為問題

症狀隨年齡增長可能進步，但症狀遭遇
的困難會隨著環境需求有所變動，不是一路的變好或是變“正常”



 自閉症類群（ASD）

Autism Spectrum Disorder (ASD)

自閉症的診斷

根據 DSM-5，個體必須在 A 部分的三個項目中均表現出持續性缺陷，並在 B 部分的四個項目中至少滿足兩項。

A. 社交溝通與社交互動的持續性缺陷



A.1. 社交情感互動的缺陷：從異常的社交應對、無法維持正常對話，到很少分享興趣或情感。



A.2. 用於社交互動的非語言溝通行為缺陷：從語言與非語言溝通整合不佳、眼神接觸異常，到完全缺乏臉部表情。



A.3. 發展、維持與理解人際關係的缺陷：從難以調整行為以適應不同社交情境，到對同儕缺乏興趣。

B. 局限、重複的行為、興趣或活動模式



B.1. 刻板或重複的動作、物品使用或語言：如簡單的動作刻板、排列玩具、仿說。



B.2. 堅持同一性，對常規僵化固守：如因微小改變而極度痛苦、困難於過渡轉換、僵化的思考模式。



B.3. 高度局限、執著的興趣，且強度或焦點異常：如強烈依戀不尋常的物品、過度局限的興趣。



B.4. 對感官輸入過度反應或反應不足：如對疼痛/溫度看似不在乎、對特定聲音或質地有厭惡反應、過度嗅聞或觸摸物體。

症狀必須在早期發展階段就出現，並對當前功能造成臨床上顯著的損害。

Autism Spectrum Disorder: A Review. Hirota T, King BH. JAMA. 2023;329(2):157-168. doi:10.1001/jama.2022.23661.

流行病學

全球盛行率：約 **10 / 1,000**

美國CDC (2020年數據)：**1 / 36**
(每1,000名8歲兒童中有27.6名)

男性：「每1,000名中43.0名」

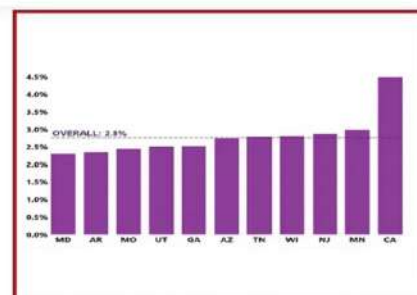
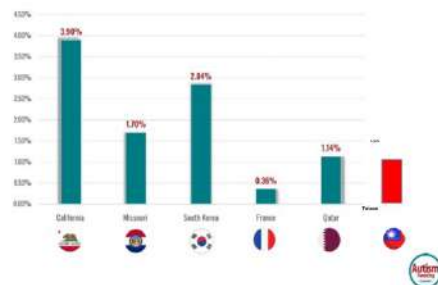
女性：「每1,000名中11.4名」

男女比例：約 **4:1** (3.8:1 至 4.2:1)

40% are nonverbal
44% Have average or above average intellectual ability
31% have an intellectual disability

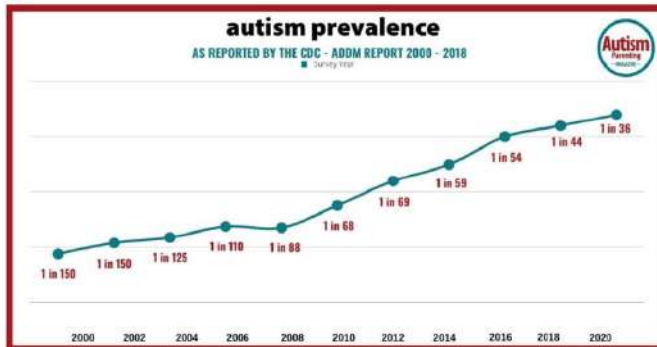
Although autism can be diagnosed before a child reaches the age of two, most kids are diagnosed only after the age of

4



1. Autism Spectrum Disorder: A Review. Hirota T, King BH. JAMA. 2023;329(2):157-168. doi:10.1001/jama.2022.23661.
2. <https://www.autismparentingmagazine.com/autism-statistics>

逐年上升的盛行率



1. Autism Spectrum Disorder: A Review. Hirota T, King BH. JAMA. 2023;329(2):157-168.
2. <https://www.autismparentingmagazine.com/autism-statistics>

盛行率上升的可能原因

- 診斷標準的變更與擴展
- 篩檢與診斷工具的效能提升
- 公眾與專業人士意識的提高
- 早期療育等服務的可及性增加

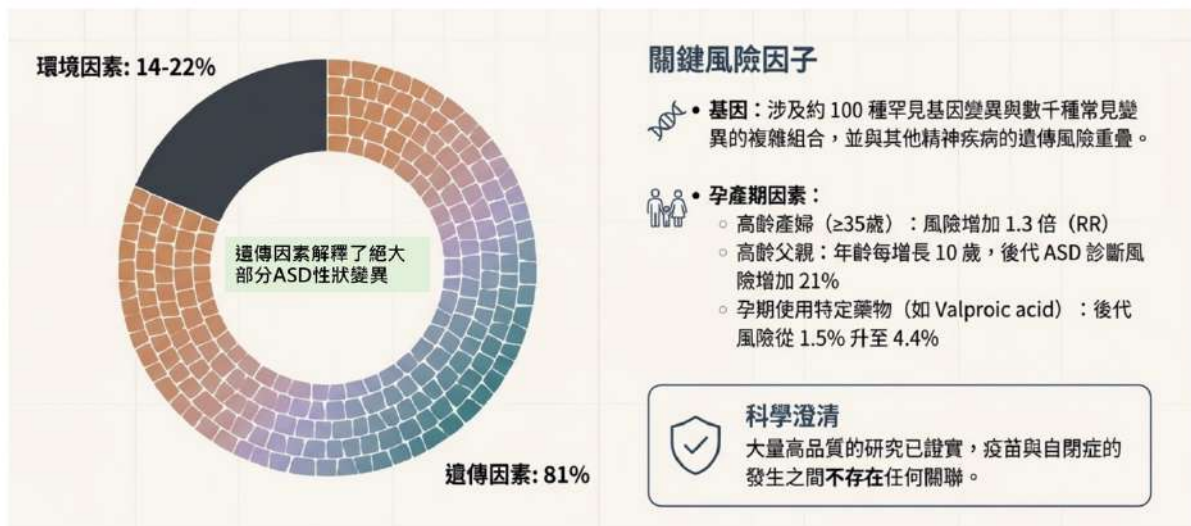
性別差異

男孩與女孩的盛行率比約為 **4:1**
(3.7% vs 0.9%)。



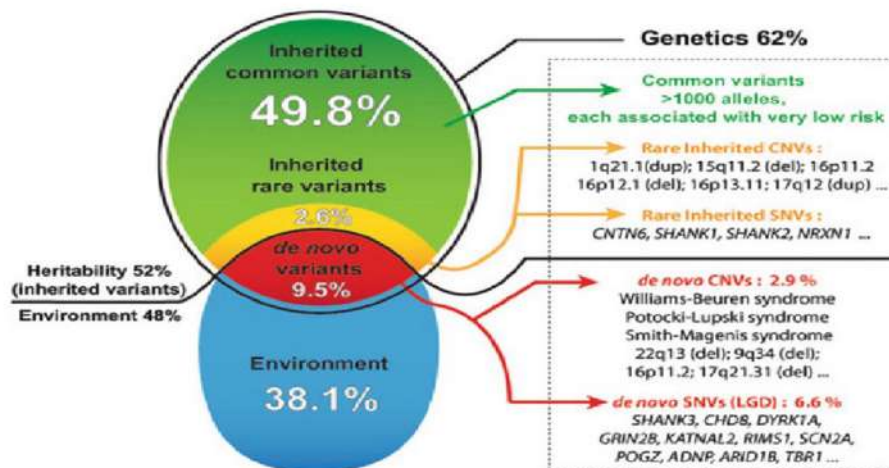
部分研究顯示，女性可能更擅於或更有能力掩飾其社交溝通困難（此現象稱為「偽裝」Camouflaging），可能導致診斷不足。

自閉症的成因



Autism Spectrum Disorder: A Review. Hirota T, King BH. JAMA. 2023;329(2):157-168. doi:10.1001/jama.2022.23661.

潛藏在一般人的基因裡面



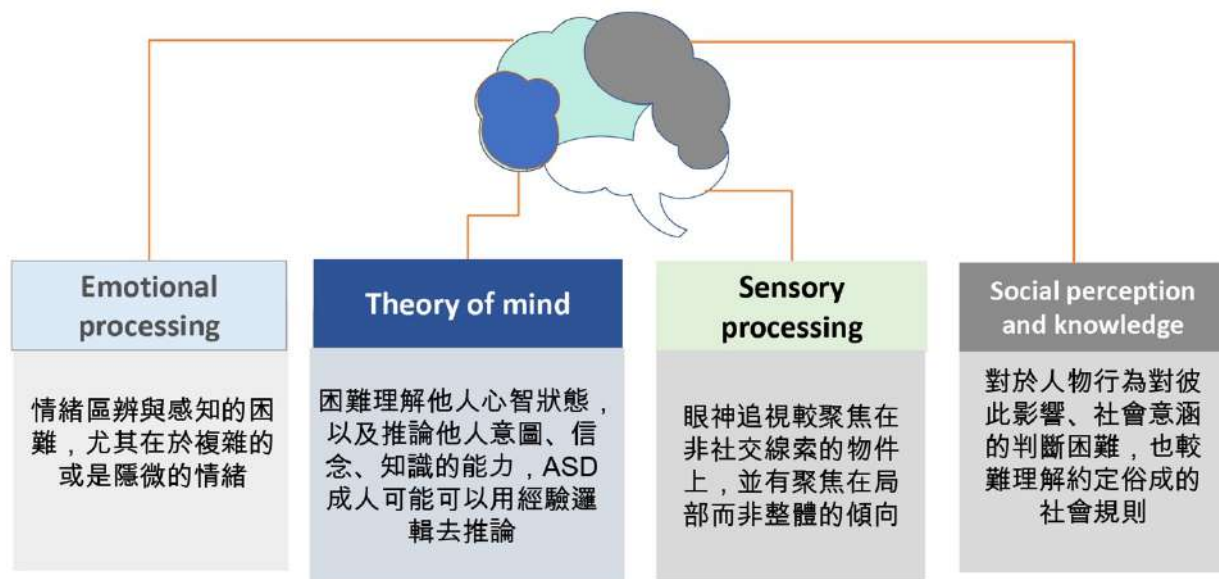
Huguet et al, The Genetics of Autism Spectrum Disorders, 2016

ASD 的認知特點

Cognitive & Social Profile of ASD



自閉症相關的社會認知困難



社交知覺處理

早期行為證據 (脆弱手足 vs. 低風險嬰兒)

- 新生兒期 (6-10天)**
 - 對類臉孔刺激和生物運動的偏好較低 (Di Giorgio et al., 2016)。
- 5個月**
 - 未能表現出典型的對直接凝視的偏好 (Nele et al., 2015)。
- 12個月**
 - 對語音的注意力下降 (Curtin & Vouloumanos, 2013)。

腦科學證據 (神經反應差異)

- 9個月大的脆弱手足**在觀看微笑表情時，P400潛伏期更短，Nc波幅更低，表明注意力分配較少 (Key et al., 2015)。
- 4-6個月大的脆弱嬰兒**對視覺和聽覺社交刺激的額葉和顳葉反應減弱 (Lloyd-Fox et al., 2013)。
- ASD兒童的父母**在觀看臉孔時，未能表現出典型的右半腦N170反應優勢 (Dawson et al., 2005)，支持狀態獨立性 (G&G 3)。

臉孔掃描

ASD個案及其青少年手足表現出更多的「嘴部注視」而非典型的「眼部注視」(Dalton et al., 2007)。具備「廣泛自閉症表型」(BAP)的父母在處理情緒臉孔時也更依賴嘴部區域 (Adolphs et al., 2008)。

內隱處理

在「臉孔後效應」範式中，ASD親屬的臉孔辨識較少受到先前經驗的影響，顯示內隱的臉孔編碼規範更新存在異常 (Fiorentini et al., 2012)。

神經基礎

雖然行為表現正常，但ASD父母在情緒配對任務中，杏仁核和梭狀迴的活化增強且反應延遲 (Yucel et al., 2015)。

心智理論

一個核心理論主張，ASD的核心社交溝通困難源於「心智理論」（Theory of Mind, ToM）的受損——即將心理狀態（信念、慾望、意圖）歸因於自己和他人的能力。

什麼是心智理論？

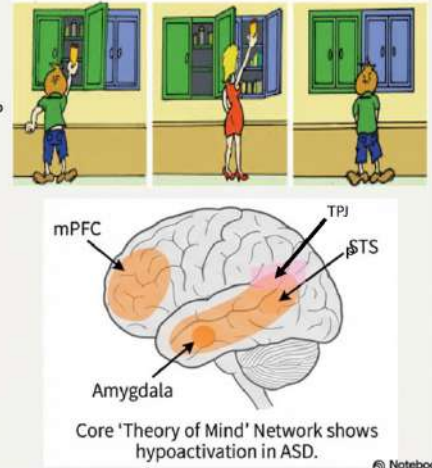
- 推斷他人心理狀態的能力。
- 理解他人有自己的想法、感受和觀點，且可能與自己不同。
- 它使我們能夠解釋和預測他人的行為。

ASD中ToM缺陷的表現

- 難以理解他人有自己的意圖和觀點。
- 在理解欺騙、諷刺、幽默和非字面語言方面有困難。
- 在經典的「錯誤信念」測試中表現不佳。

神經生物學基礎

與社交推理任務期間，核心ToM區域的活動不足（hypoactivation）有關。



語用學（Pragmatics）： 社交溝通的核心挑戰

在社交情境中恰當使用語言的能力。



自閉症的典型特徵

- **字面解讀（Literal Interpretation）**：難以理解譬喻、幽默或言外之意。
- **仿說（Echolalia）**：重複他人說過的話語或片語，可能是為了輔助溝通或理解。
- **學究式言談（Pedantic Speech）**：使用過於正式、不自然的詞彙和語句，彷彿在背誦書面語。
- **特殊興趣相關的話題**：難以轉換話題，或在對話中過度談論自己的特殊興趣。

💡 核心洞見：語用障礙可以是首要的困難，即使其他語言成分（如語法、語義）完整甚至優異的情況下依然存在。

Vogindroukas I, Stankova M, Chelas EN, Proedrou A. Language and Speech Characteristics in Autism. Neuropsychiatr Dis Treat. 2022 Oct 14;18:2367-2377.

恐懼迴路的中樞：杏仁核 (Amygdala) 的結構與功能改變



情緒調節的差異

情緒調節 (ER) 與失調 (ED) 是影響 ASD 兒童適應功能的關鍵因素



情緒調節 (Emotion Regulation - ER)

引用 Gross (1998) 的模型，ER 是個體為達成特定目標而評估、維持及調整自身情緒的動態過程。

關鍵過程：

1. 情境選擇 (Situation Selection)
2. 情境修正 (Situation Modification)
3. 注意力部署 (Attentional Deployment)
4. 認知改變 (Cognitive Change)
5. 反應調節 (Response Modulation)

策略分類：適應性 (Adaptive) 與非適應性 (Maladaptive)



情緒失調 (Emotion Dysregulation - ED)

指個體難以用社會可接受或具適應性的方式來管理和回應情緒經驗。

表現為強烈、迅速升級且調節不良的負面情緒反應。

對 ASD 的影響：ASD 兒童中約有 60% 存在 ER 問題，這與學業表現惡化、問題行為增加及社交關係減少密切相關。



如何理解 ASD 孩子

光譜上的每一個人，都是獨一無二的個體

自閉症光譜障礙 (ASD) 的各項向度特徵本身就是一條光譜——每個孩子在社交、溝通、感官、認知等各個向度上，可能呈現截然不同的強度與表現方式。特徵的樣貌也會因**認知功能**、**語言能力**、**性格特質**，以及**是否存在共病**而產生極大差異。

光譜的多樣性

相同的診斷，在不同孩子身上可能有完全不同的表現，無法一概而論。

場域的差異

同一個孩子在家庭、學校、社區等不同場域，所受到的影響程度可能天差地別。

人生階段的變化

特徵的影響隨著成長階段而變化，幼兒期、學齡期與青春期的挑戰各有不同。

📌 當我們談論「嚴重度」時，不同的人所關心的面向可能截然不同——有人在意認知或語言功能，有人更關注孩子能否在群體中生存，日後能否獨立謀生。嚴重度背後，藏著每個家庭最深切的期待。

怎麼理解 ASD 孩子 之二

社交互動的多樣樣貌與背後原因

活在自己的世界

對他人與社交缺乏興趣，無法從情感連結中獲得樂趣。這源於神經層面對社交酬賞的感知差異，並非刻意排斥。

有社交興趣，但霸道或佔有性強

欠缺换位思考與心智理論，情緒共感能力可能有缺損，因此傾向強迫他人配合自己，缺乏利他動機所帶來的滿足感。

社牛，但界線感不佳

無法透過觀察群體行為來評估自身行為是否恰當，看似外向，實則缺乏內建的社交規範感知器。

想社交，但困難重重

欠缺整合聲音、姿勢、表情與情境脈絡的能力；無法投他人所好，社交開啟困難，或以單向輸出、物質討好來維持關係。

自我中心、過度要求公平

欠缺認知彈性與换位思考，無法體會社交潛規則的意義，對他人期待較無感，不理解「合群」的內涵與必要性。

理解這些行為背後的神經認知成因，是與ASD孩子建立有效溝通的第一步。行為是結果，成因才是關鍵。

怎麼理解 ASD 孩子 之三

溝通與情緒調節的挑戰

溝通層面的困難

1 抓語病、雞同鴨講

語意整合與語境理解困難，注重細節與精確度，無法換位思考，因此常抓住字面意思而錯失對方真正的重點。

2 表達突兀、缺乏前因後果

不理解他人缺乏背景資訊，無法換位思考，導致說話缺乏鋪陳，讓聽者感到困惑或突兀。

3 聽不懂弦外之音

欠缺整合多元社交訊號（聲音、表情、姿勢、情境）的能力，思考回應本身極度耗能，因此傾向迴避互動以降低認知負荷。

情緒調節的困難

1 說不得、完美主義、不能輸

欠缺思考彈性，評估標準僵化、非黑即白。有缺點等於差勁，有失誤等於失敗，無法接受他人觀點或建設性意見。

2 過度詮釋、負面思考多

無法直覺正確判斷他人意圖，但又極在乎他人是否喜歡自己，害怕犯錯又缺乏自我調節能力，因此長期處於焦慮與患得患失的狀態。

3 不知何時該求助

看不出他人的欺負意圖，也不清楚在什麼情況下應該向大人或同儕求助，有時候寧可忍耐而不要涉入與人互動。

怎麼理解 ASD 孩子 之四

行為模式、感官與彈性的挑戰

✚ 無法舉一反三，說一動做一動

無法參照過去互動經驗，難以判斷他人意圖與行為脈絡，也無法預測他人行為與期待，因此每次情境對他們而言都像是全新的挑戰。

怪異行為與自我刺激

源於獨特的感官連結方式。自我刺激行為（如搖晃、拍手）往往是孩子調節內在感官狀態的自然策略，並非故意擾亂，而是一種自我安撫與調節。

⚡ 情緒起伏大、抓不到情緒脈絡

當行為計畫未完成、事情不如預期，或感官受到過度刺激時，情緒便容易崩潰。外人看似「小題大作」，對孩子而言卻是真實的神經層面衝擊。

☆ 侷限興趣與堅持偏執

對可預測、有規則、有邏輯的事務有強烈偏好。一旦計畫啟動便難以中斷，不喜歡新刺激，無法隨機應變——這是認知彈性不足的直接體現。

👂 感官敏感、反應過激

神經刺激與抑制系統的平衡不佳，使得聲音、光線、觸覺等日常感官輸入可能引發強烈的不適或情緒反應，需要環境上的配合與調整。

☐ 理解行為背後的成因，是支持 ASD 孩子最重要的基礎。每一個「問題行為」，都是一個值得探索的溝通訊號。

支持 ASD 孩子的關鍵原則

Key Principles for Supporting ASD Children

預告與固定流程

可預測的環境能大幅降低焦慮，讓孩子感到安全

Predictability and routines significantly reduce anxiety

溝通方式要直白、簡要

不要太委婉、迂迴，可以請他們表達他們所聽到的意思

Brief and straightforward wording to improve understanding

換位思考練習、社交潛規則說明

協助情境理解、情緒覺察、腳色互換扮演、隨機教育

Practice role playing, perspective taking, emotion recognition

接納刺激調節行為

接納 **stimming**（搖晃、拍手等），而非強行制止——這是孩子的自我調節方式

Accept self-regulation behaviors (stimming) rather than suppressing them

理解挫折、協助情緒連結

同理其在意及固著的點，協助連結情緒並尋找替代方案

Help them name the emotion and find the alternatives



第四章 CHAPTER 4

學習障礙

Learning Disabilities (LD)

學習障礙與腦神經迴路的關聯

The Neuroscience of Learning Disabilities



閱讀障礙 Dyslexia

語音處理迴路（左腦顳頂區）連結效率低
Inefficient phonological processing in left temporoparietal regions



書寫障礙 Dysgraphia

動作計畫與語言整合困難，影響書寫流暢度
Difficulty integrating motor planning and language for writing



智力正常，特定困難

學習困難來自特定神經迴路，非整體能力問題
Intelligence is intact — difficulty is circuit-specific, not global

學習障礙孩子的心理經驗

Psychological Experience of Children with LD



「我努力了，可是還是不行……」

"I tried so hard, but I still can't do it..."

習得無助感

長期努力卻看不到成果，容易形成「做了也沒用」的信念

Repeated failure despite effort leads to learned helplessness

逃避是保護機制

自我效能低落、逃避學習是自我保護，而非懶惰

Avoidance is a protective response, not laziness

支持學習障礙的實用策略

Practical Strategies for LD



多感官學習

視覺+聽覺+動覺並用，強化神經迴路，讓學習更容易留下印記

*Multi-sensory learning
strengthens neural pathways*



輔助科技

語音轉文字、有聲書、拼字輔助—
—繞過障礙點，建立自信

*Assistive technology bypasses
barriers and builds confidence*



優勢導向

聚焦孩子能做到的，以小成功累積動力與自我效能感

*Focus on strengths to rebuild
motivation and self-efficacy*



第五章 CHAPTER 5



焦慮與情緒調節困難

Anxiety & Emotional Dysregulation

神經多樣性與焦慮的交疊

Neurodiversity & Anxiety: The Overlap

40–50%

共病焦慮比例

ADHD、ASD、學習障礙孩子同時有焦慮的比例高達 40–50%

of children with ADHD, ASD, or LD also have anxiety

焦慮的「隱形面貌」

焦慮常以拒絕上學、身體症狀（頭痛、肚子痛）、情緒爆發呈現，而非直接說「我很擔心」

Anxiety often appears as school refusal, somatic complaints, or meltdowns — not "I'm worried"

情緒調節的發展與支持

Developing Emotional Regulation



💡 共同調節 Co-regulation

情緒調節能力需透過「共同調節」學習——大人先穩定，孩子才能穩定

Children learn regulation through co-regulation with calm adults

🗨️ 命名情緒

「Name it to tame it」——幫孩子說出感受，能降低杏仁核活化，讓情緒更快平靜

"Name it to tame it" — labeling emotions reduces amygdala activation



家庭支持的核心原則

Core Principles for Family Support

從「為什麼不行」到「怎麼幫」

From "Why Can't You?" to "How Can I Help?"

❌ 舊框架

「為什麼你就是不行？」
批評孩子的意志力或態度

✅ 新框架

「這個孩子在哪裡卡住了？」
好奇心取代批判，尋找支持點

行為背後必有原因

每個行為都是孩子用來應對困難的方式。先問「卡在哪裡」，才能找到真正的幫助切入點。

Every behavior has a reason — ask "where is this child stuck?"

減少批評，增加好奇

好奇心是改變親子關係的第一步，也是建立信任的基礎。

Less criticism, more curiosity — the first step to change

打造神經友善的家庭環境

Creating a Neuro-Friendly Home



可預測性

固定作息、提前預告變化，讓孩子知道接下來會發生什麼

Consistent routines and advance notice of changes



感覺友善

注意光線、聲音、觸感等感覺刺激，為孩子打造舒適的感覺環境

Attend to lighting, sound, and texture for sensory comfort



優勢導向

每天找到孩子做到的事，給予具體、真誠的讚美

Find something the child did well every day – give specific praise

給助人工作者的提醒

A Note for Helping Professionals



家長也需要被支持

照顧神經多樣性孩子的壓力與孤立感是真實的——家長的身心健康同樣重要

Parents need support too – caregiver burnout is real and valid

跨專業合作

教師、治療師、醫師緊密合作，是最有效的支持系統

Interdisciplinary collaboration – teachers, therapists, physicians – is the most effective support system

不同，不是不好； 但困難需要被看見與支持

Different, Not Less; difficulties should be seen and supported

☀ 每個孩子都有獨特優勢

每一個神經多樣性孩子都有獨特的優勢與潛能，等待被看見與支持

Every neurodiverse child has unique strengths and potential

🌱 理解是支持的起點

感謝您今天的學習與陪伴。您的理解，將成為孩子成長路上最重要的力量。

Understanding is where support begins — thank you for being here today 🌱



感謝聆聽~



台大醫院 國立臺灣大學醫學院附設醫院
NTUH NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY HOSPITAL



亞東紀念醫院
FAR EASTERN MEMORIAL HOSPITAL



亞東紀念醫院兒童發展中心

From Mental Health to Life Skills Coach

從心理健康支持到生活陪跑師：日常生活技能的培養

Barry Fell LCSW

This is typical..

現今青少年的典型寫照



Technology changed childhood: We went from play to screens

科技改變了童年：我們從實體遊戲走向了虛擬世界



Therapy is not coaching..

心理治療不等於生活輔導



8 critical life skills every young person should learn..

每位年輕人都應學會的 8 項關鍵生活技能



Skills should be practiced under stress..

生活技能必須在壓力情境下反覆演練與實踐



Transfer test - from treatment to independence

生活技能轉移測試：從接受治療走向獨立自主



SUCCESS

The process of skills development

生活技能發展五階段



Why failure matters

為什麼「失敗」是不可或缺的成長關鍵



The process of skills development

生活技能發展五階段



CLINICAL EXCELLENCE IN ADOLESCENT RESIDENTIAL TREATMENT

青少年住宿型機構處遇中的臨床卓越實務

SEEING THE WHOLE CHILD, NOT JUST THE SYMPTOMS

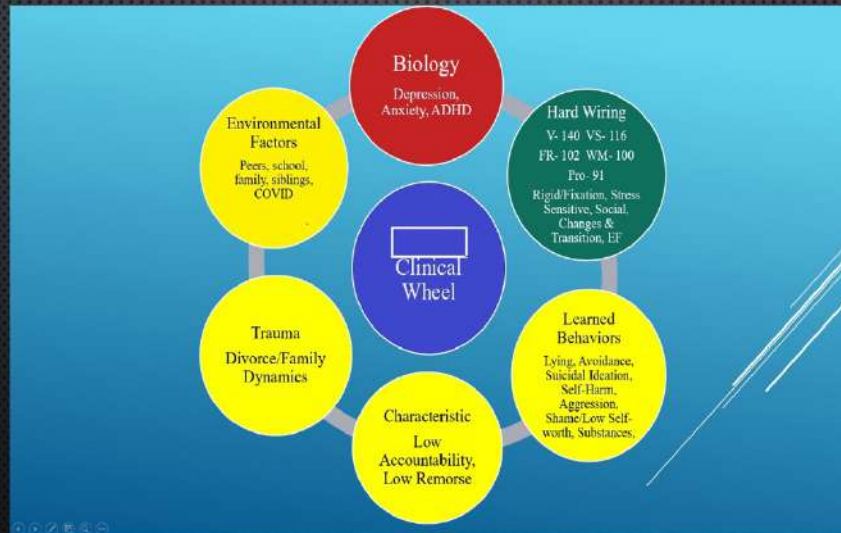
看見完整的孩子 · 而非僅見症狀

DREW DAVIS, LCSW, CLINICAL DIRECTOR, TELOS

WHEN INFORMATION IS LACKING, ALL
CHOICES ARE HAZARDOUS

當資訊不足時 · 所有選擇都充滿風險

THE CLINICAL WHEEL 臨床評估輪盤



WHAT IS CLINICAL EXCELLENCE?

卓越臨床照護實務定義？

ACCURATELY UNDERSTANDING WHY A CLIENT IS STRUGGLING AND TARGETING THE TRUE DRIVERS OF DYSFUNCTION.

精準理解個案陷入掙扎的原因，並確認導致功能失調的根源

COMPREHENSIVE ASSESSMENT 全方位評估

ACCURATE CASE CONCEPTUALIZATION 精準個案概念化

STRONG THERAPEUTIC RELATIONSHIPS 穩固治療關係

INDIVIDUALIZED TREATMENT 個別化處遇方案

MEASURABLE OUTCOMES 可衡量的成效評估

THE PROBLEM

臨床面臨的問題

- TWO TEENAGERS CAN HAVE THE SAME DIAGNOSIS BUT REQUIRE COMPLETELY DIFFERENT TREATMENT

兩位診斷相同的青少年，需要不同的治療策略

- DEPRESSION MAY BE DRIVEN BY TRAUMA, ADHD, LEARNING DISORDERS, FAMILY CONFLICT, OR BIOLOGY.

憂鬱症的背後可能是由創傷、ADHD、學習障礙、家庭衝突或生理因素所驅動

CLINICAL EXCELLENCE

卓越臨床照護實務

MOVE BEYOND 'WHAT DIAGNOSIS?' TO 'WHAT EXPLAINS THIS BEHAVIOR?'

不只問「診斷是什麼？」，更要探究「是什麼造成這些行為？」

BIOLOGY

生物學

GENETICS, SLEEP, MEDICATION RESPONSE, MEDICAL CONDITIONS,
NEUROCHEMISTRY

遺傳基因、睡眠品質、藥物反應、身體疾病狀況、大腦神經化學

HARDWIRING

天生神經結構

ADHD, EXECUTIVE FUNCTIONING, LEARNING DISORDERS, AUTISM
TRAITS, IQ, WORKING MEMORY, PROCESSING SPEED

ADHD、執行功能、學習障礙、自閉特質、智商 / 認知能力、工作記憶、處理速度

LEARNED BEHAVIORS

後天習得行為

EVERY BEHAVIOR SOLVES A PROBLEM. ASK: WHAT PURPOSE DOES THIS BEHAVIOR SERVE?

每一種行為都在解決問題。請思考：這個行為背後滿足了什麼內在目的與需求？

CHARACTERISTICS

人格特質

PERSONALITY DISORDER TRAITS

人格障礙、長期固著的應對模式

TRAUMA

創傷

TRAUMA CHANGES BELIEFS, RELATIONSHIPS, IDENTITY, AND
NERVOUS SYSTEM FUNCTIONING

創傷會改變信念、人際關係、自我認同與自律神經系統運作

ENVIRONMENTAL FACTORS

環境因素

FAMILY, SCHOOL, PEER, AND CULTURAL INFLUENCES SHAPE
FUNCTIONING

家庭、學校、同儕和文化因素，都會影響個案的功能表現

CLINICAL EXCELLENCE IN ACTION

卓越臨床照護整合實踐

PSYCHIATRY, SCHOOL SUPPORTS, EMDR, FAMILY THERAPY,
EXECUTIVE FUNCTIONING COACHING, RELATIONSHIP-BASED
TREATMENT

整合精神醫療、學校支持系統、創傷治療、家庭治療、執行功能生活陪跑、以關係為核心的治療

THE TREATMENT TEAM

治療團隊

EVERY ADOLESCENT IS STAFFED BY THE FULL TREATMENT TEAM
EVERY TWO WEEKS — REVIEWING ALL SIX DOMAINS OF THE
CLINICAL WHEEL TOGETHER

治療團隊每兩週會針對每位青少年進行一次完整的個案討論—共同回顧臨床評估輪盤的六個領域

MEASURING PROGRESS TOWARD GOALS

衡量目標達成進度

BEFORE EVERY STAFFING, WE GATHER SPECIFIC, MEASURABLE
INFORMATION TIED TO EACH ADOLESCENT'S INDIVIDUALIZED
GOALS

每次個案討論前，我們收集每個青少年個人化目標相關的具體資訊

THE MISSING INGREDIENT

遺漏的關鍵因素

THE CLINICAL WHEEL TELLS US WHAT TO TREAT.
RELATIONSHIPS DETERMINE WHETHER TREATMENT WORKS.

臨床評估輪盤告訴我們應該治療什麼。而人際關係則決定治療能否發揮效果

FINAL THOUGHTS

結語

- BE CURIOUS 保持好奇心
- THINK SYSTEMICALLY 系統性思考
- TREAT THE WHOLE PERSON 關注全人健康

Autism, Neurodiversity, and Communities of Belonging: A Community Psychology Perspective

自閉症、神經多樣性與社區歸屬感：社區心理學的視角

Toshiaki Sasao, Ph.D.

International Christian University, Japan

sasao@icu.ac.jp

8/24/26

1

Goals

學習目標

1. WIDEN THE LENS 擴大視野

- Move beyond diagnosis and individual intervention to consider **relationships, settings, communities, systems, and culture**
超越診斷與個人介入，全面考量人際關係、場域環境、社區、體系與文化脈絡

2. LEARN FROM LIVED EXPERIENCE 從當事人的生命經驗中學習

- Bring together **clinical knowledge, neurodiversity, and perspectives from autistic people**, especially recent work and practices from Japan
整合臨床專業知識、神經多樣性觀點與自閉症當事人的視角，並特別參考日本近期的研究與實務經驗

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

2

Goals

學習目標

3. TRANSLATE UNDERSTANDING INTO PRACTICE 將理解轉化為實踐行動

- Ask how **people and environments can adapt together** so that autistic people can not only receive support, but **participate, belong, and matter**.
探討個人與環境如何「雙向調適」，使自閉症者不僅是接受支持，更能實質參與、感受到歸屬，並確認自己的存在具有價值

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

3

A Life that Defies a Simple Explanation

一段無法以單一因素解釋的人生

- Jason Arday (1985-2026)



- Professor of Sociology of Education, Cambridge University
劍橋大學教育社會學教授
- Diagnosed with autism in childhood
幼年即被診斷為自閉症
- Resigned in early August 2026 amid allegations regarding his academic work and public scrutiny
2026年因學術爭議指控與公眾審視壓力而辭職
- Found dead shortly afterward, at age 41; cause not known or established
不久後被發現身亡，享年41歲；死因尚未確定

Where do we look to understand a human life?

The person? The diagnosis? Relationships?

Institutions? Culture?

要理解一個人的一生時，我們該看向何處？是看這個人、看診斷結果、看人際關係、看體制制度還是看文化環境？

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

4

Autism: What We Know and What We Should Not Assume

自閉症：我們已知的與我們不應有的預設

What we Know 我們已知的	What We Should <u>Not</u> Assume 我們不該做的預設
Autism is real and heterogeneous. 自閉症是真實存在的，而且具有異質性。	Diagnosis explains the whole person. 診斷能代表一個人的全部
Individual needs matter. 個別需求至關重要	Difficulties always lie within the person. 問題與困難永遠出在個體身上
Context affects functioning. 環境會深刻影響適應功能	Functioning is the same across settings. 在不同場域的適應功能都一樣
Professional expertise is valuable. 專業知識很有價值	Professionals hold all relevant knowledge. 專業人員掌握了所有相關知識
Adaptation may be useful. 適應或許有幫助	Looking successful means doing well. 看起來適應良好，就代表實際上過得很好

A diagnosis tells us something important – but not everything.

診斷告訴了我們重要資訊，但絕非全貌

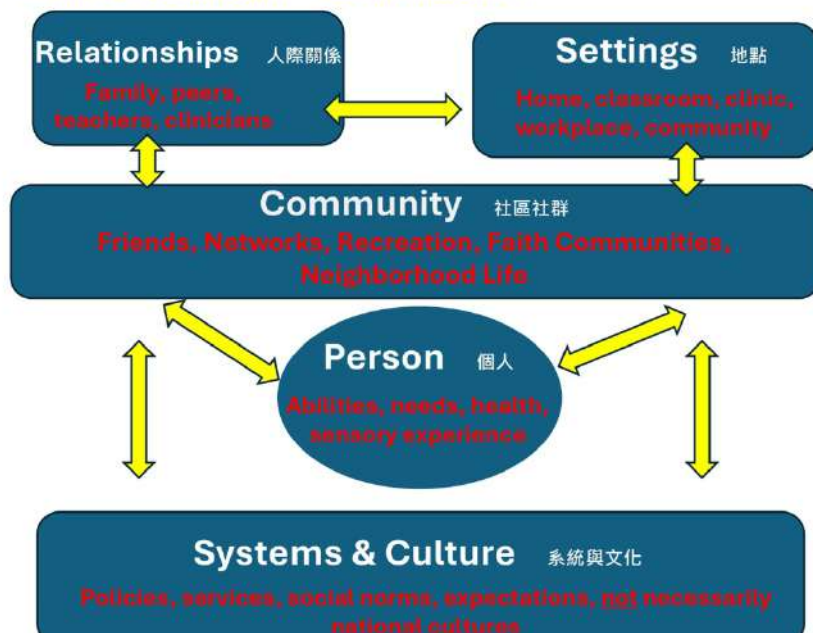
8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

5

Where Should We Look to Understand Human Functioning?

我們應從哪些面向理解一個人的功能表現？



The same person may function very differently in diverse environments.
同一個人處在不同環境，表現可能天差地別

6

What is Community Psychology?

何謂「社區心理學」？

• Community Psychology (CP) studies “**people in context**” and asks how individuals, communities, relationships, settings, and systems in a single cultural context or across diverse cultures can work together to empower and support well-being.

社區心理學研究「情境脈絡中的人」，探討在同一文化脈絡或不同文化之中，個人、社區、人際關係、場域與體系如何共同發揮作用，以促進賦權與福祉。

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

7

What is Community Psychology?

何謂「社區心理學」？

1.Ecology Where and with whom does the difficulty occur?

1. 生態學：困難發生在何處？涉及哪些人？

2.Prevention What secondary problems could we prevent?

2. 預防：我們可以預防哪些次要問題？

3.Empowerment Whose goals and knowledge count?

3. 賦權：誰的目標與知識受到重視？

4.Participation & System Change what can change around the person?

4. 參與與系統變革：個人周遭的哪些面向可以改變？

Therefore, the unit of concern is not only the individual, but also the ecology!

因此，我們關注與介入的對象不只是個人，也包括其所處的整體生態環境！

“What is wrong?” → “What is happening here, and what could change?”

焦點從「哪裡出了問題？」轉變為「這裡發生了什麼事，以及可以做出哪些改變？」

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

8

What Does This Mean for Autism?

這對自閉症支持意味著什麼？

One Simple Case: A 14-year-old autistic student begins refusing school.

案例分析：一位十四歲的自閉症學生開始出現「拒學 / 懼學」現象

Where do we look? 我們從哪裡入手？	What might we find? 我們可能會發現什麼？	What might we do? 我們該做些什麼？
Individual 個人層面	Sensory sensitivity, anxiety, difficulty with sudden change 感官敏感、焦慮、難以應對突發變動	Coping strategies, communication support, anxiety treatment 因應策略、溝通支持、焦慮處置
Relationships 人際關係	Bullying, misunderstanding with teachers, family conflict around attendance 同儕霸凌、與教師溝通誤解、因上學與出勤問題引發的家庭衝突	Peer support, teacher consultation, family support 同儕支持、教師諮詢、家庭支持

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

9

What Does This Mean for Autism?

這對自閉症支持意味著什麼？

One Simple Case: A 14-year-old autistic student begins refusing school.

案例分析：一位十四歲的自閉症學生開始出現「拒學 / 懼學」現象

Where do we look? 我們從哪裡入手？	What might we find? 我們可能會發現什麼？	What might we do? 我們該做些什麼？
School Setting 學校場域	Noisy classroom, unpredictable schedule, implicit rules, few quiet spaces 嘈雜混亂的教室、作息無法預測、潛規則過多、缺乏安靜空間	Predictable routines, quiet space, explicit instructions, flexible participation 建立可預測的常規、設置安靜空間、明確指令、彈性參與機制
System/Community 社區體系	Rigid attendance policy, poor coordination among school/health services, few alternative supports 僵化的考勤制度、學校/醫療服務之間協調不力、替代支持措施少	Adjust policy, coordinate services, create alternative participation pathways 調整政策、協調服務、創造替代參與途徑

Both the student and the ecology or environment matter. The fit between them matters --- in CP, it is called the person-environment fit. So where should intervention occur?

學生和生態環境都很重要。二者之間的匹配度至關重要 - 在社區心理學中，這稱為個人與環境的適配。那麼，介入該從哪裡開始呢？

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

10

Autism is Real – But it is also Heterogeneous!

自閉症是真實存在的 - 但它也具有極高度的異質性！

- Autism is a meaningful clinical diagnosis. However, one diagnosis does not describe one kind of person!
自閉症是一項具臨床意義的診斷，但同一項診斷，並不代表每個人都具有相同的樣貌與特質！
- Different developmental profiles (i.e., communication, cognition, sensory experience, and adaptive functioning) 不同的發展特徵（例如：溝通、認知、感覺體驗和適應功能）
- Different support needs 多元的支持需求
 - Frequent co-occurring conditions 經常伴隨其他共存狀況
- Diagnosis identifies a pattern, but does not tell us the whole life.
診斷可以辨識出某種模式，但並不能告訴我們人生的全貌。
- Saito *et al.* (2020): The Hiroasaki (Japan) population study on 5-year-olds
日本弘前市5歲幼童流行病學研究報告
 - Among children identified with ASD, only 11.5% have ASD without another neurodevelopmental (NDD) condition; most had at least one co-existing condition. A diagnosis is a label but not a complete developmental profile!
在被診斷為自閉症譜系障礙（ASD）的兒童中，只有11.5%的兒童沒有其他神經發育障礙（NDD）；大多數兒童至少合併一種疾病。診斷標籤能提供重要資訊，但無法呈現完整的發展特徵！

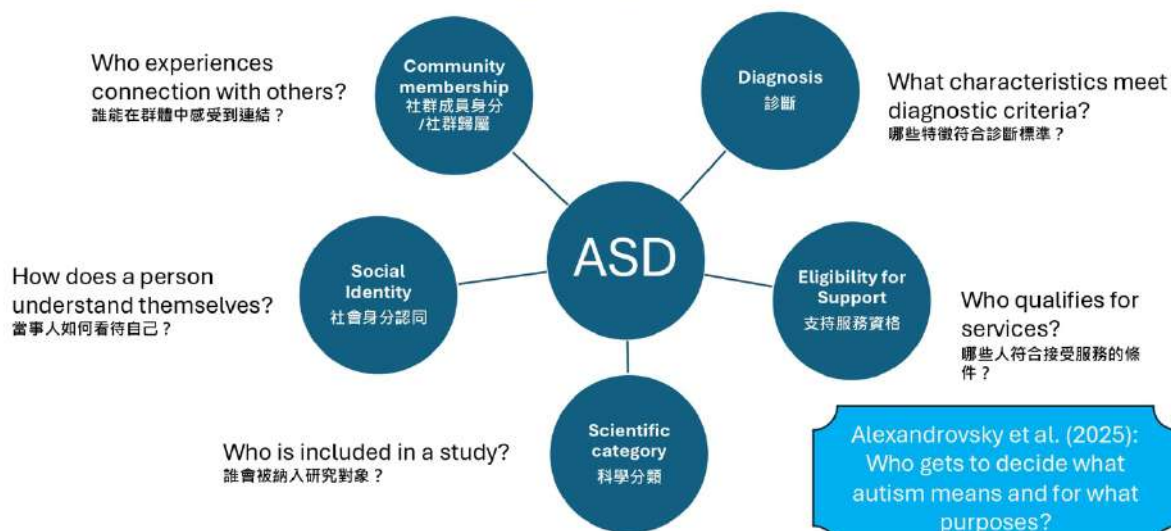
8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

11

Who Defines Autism and for What Purpose?

誰在定義自閉症？目的是什麼？



8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

12

Neurodiversity Does not Mean “No Treatment”

神經多樣性並不代表「完全不需要治療介入」

Clinical Care 臨床醫療照護	Neurodiversity 神經多樣性	Community Psychology 社區心理學
Reduce suffering 減輕痛苦	Respect neurological differences 尊重神經特質差異	Examine person-environment fit 檢視人與環境的適配度
Support communication and functioning 支持溝通與日常適應功能	Protect dignity and agency 維護尊嚴和自主權	Change environments as well as people 改變個人的同時也改變環境
Address health and co-occurring conditions 處理健康問題及其他共存狀況	Value lived experience 重視生活經驗	Promote participation and belonging 促進實質參與及歸屬感
Provide needed support 提供必要協助	Avoid unnecessary normalization 避免不必要的正常化	Prevent secondary harm 預防次級傷害

*These perspectives are competing, they can complement one another.

“Reciprocal Adaptation” 這些觀點並非彼此競爭，而且透過「雙向調適」可以互相補充
(i.e., adaptation need not flow in only one direction!) 適應並非只能單向進行！

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

13

What Counts as “Normal”? Norms, Interpretation, and Fit

何為「正常」？規範、解讀與契合度

*Autistic characteristics are expressed by individuals, but they are interpreted within social and cultural environments. Note that culture here does not necessarily refer to national or geopolitical culture.

自閉症特徵由個體表現出來，但這些特徵是在社會和文化環境中被解讀的。需要注意的是，這裡的文化不一定指國家或地緣政治文化。

What is Expected? 常態期待

- Eye contact 眼神接觸
- Conversational timing 對話節奏
- Emotional expression 情緒表達方式
- Independence vs. Interdependence 獨立vs.相互依賴
- Conformity to group routines 遵守團體規範
- Tolerance for unusual interests or behavior 對特殊興趣或行為的包容度
- Flexibility in classroom or workplace participation 課堂或工作場所參與的彈性

What Happens when Someone Differs? 當個體展現差異時會發生什麼事？

- Is the difference noticed? 這種差異是否被察覺？
- Is it interpreted as rude, immature, uncooperative, or disordered? 是否被解讀為粗魯、不成熟、不合作、或具有障礙？
- Is accommodation possible? 是否可以做出調整？
- Is the person expected to hide or compensate for the difference? 是否要求當事人隱藏這些差異，或以其他方式加以掩飾？
- Does the environment change at all? 環境本身是否有任何改變？

Culture does not create autism. Social norms can shape whether neurological differences become barriers.

文化並非自閉症的成因，社會規範會影響神經發育差異是否會成為障礙。

8/24/26

14

What Do Autistic Adults in Japan Tell Us?

日本成年自閉症當事者告訴我們的事

Harada et al. (2025) interviewed 7 late-diagnosed autistic adults in Japan

訪談了7位成年後才確診的自閉症者

The following are some of their experiences: Harada

- **Feeling Different:** “I knew something was different, but didn’t always know why.”
感受到與眾不同：「我知道自己和別人有些不同，卻一直不明白原因」
- **Being Misunderstood:** Bullying, stigma, social misunderstanding
長期被誤解：經歷霸凌、汙名化與人際誤解
- **Diagnosis as Both Explanation and Complication:** Relief, uncertainty, mixed emotions.
診斷帶來釋懷，也帶來複雜心情：鬆了一口氣，卻也夾雜著不確定性與複雜情感
- **Wanting Acceptance:** Not simply “better social skills,” but recognition and belonging.
渴望接納與包容：他們需要的絕非只是被要求去學「更好的社交技巧」，而是獲得真正的肯認與歸屬感。

What people need is not always visible from the diagnosis.
人們的需求並不總是能從診斷結果中看出。

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

15

When Successful Adaptation Has a Hidden Cost

當表面成功的適應伴隨著隱藏的代價

What Others May See 外界所看見的表象

- **Socially Appropriate Behavior** 符合社會期待的行為
- **Eye Contact** 眼神接觸
- **School Attendance** 學校出勤率
- **Successful Work Performance** 工作表現優異
- **“Coping Well”** 適應良好

What May Remain Hidden 可能隱藏的真實代價

- **Exhaustion** 精疲力竭
- **Anxiety** 焦慮
- **Constant Self-Monitoring** 持續的自我監控
- **Loss of Authenticity** 失去真實感
- **Fear of Rejection** 害怕被拒絕
- **Burnout** 身心耗竭

Masking and Camouflaging: Is this adaptation sustainable,
and what is it costing the person?

偽裝與掩飾：這種適應方式能否持續？當事人又為此付出了什麼代價？

Oshima et al. (2024); Tamura et al. (2025)

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

16

Are Communication Difficulties Located in One Person? (Kumagaya, 2024)

溝通障礙是否只源自其中一方？

Traditional View

傳統觀點

Autistic Person
自閉症者



Communication Deficit
溝通能力缺陷

Relational View

關係系統觀點

Autistic Person
自閉症者



Communication Partner
溝通對象



Social Norms
社會規範

Communication happens between people, and social norms determine whose communication style is treated as the standard.

溝通發生在人與人之間，而社會規範決定了哪一種溝通方式被視為標準。

Kumagaya (2024) Ikebuchi (2023)

People themselves should also participate in producing that understanding > Tojisha Kenkyu
當事人也應參與相關理解與知識的形成

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

17

Japan's Tojisha-Kenkyu(當事者研究): A Neurodiversity-Informed Participatory Approach 以神經多樣性觀點為基礎的參與式方法

***Instead of asking only "What deficit does this person have?", ask "How does this difficulty actually happen?"**

不要只問「這個人有哪些缺陷？」，而要進一步探問「這項困難實際上是如何發生的？」

• Tojisha –Kenkyu (當事者研究)

- A peer-led, collaborative process in which people directly experiencing difficulties investigate their own experiences, identify recurring patterns, develop shared language, and explore ways of coping or living with those difficulties.
一種由同儕主導、共同協作的實踐歷程：面臨困境的當事者親自探究自身的生活經驗、辨識反覆出現的行為模式、發展出共通的描述語言，並共同摸索因應或與困難共存的方法。

• Origins at "Urakawa Bethel House," Hokkaido, Japan around 2001

- Began among people living with psychiatric difficulties
最初是在患有精神疾病的人群中進行的。

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

18

Japan's Tojisha-Kenkyu(當事者研究): A Neurodiversity-Informed Participatory Approach 一種考慮神經多樣性的參與式方法

***Instead of asking only "What deficit does this person have?", ask "How does this difficulty actually happen?"**

不要只問「這個人有哪些缺陷？」，而要進一步探問「這項困難實際上是如何發生的？」

- **How Does it Add to Neurodiversity?** Cf. Kumagaya (2024), Ayaya (2025)
它如何補充神經多樣性的實務觀點？

1. the person becomes a knowledge producer. 成為知識的生產者
2. The goal is understanding before normalization. 目標是在規範化之前先理解
3. Knowledge is co-produced. 知識是共同創造的
4. **Change** can occur on both sides - person & environment. 改變可以發生在人與環境的雙方

Neurodiversity becomes practical when lived experience can influence both the explanation and the intervention.
當當事人的生命經驗能夠影響我們如何解釋問題及採取介入，神經多樣性觀點才真正落實於實務。

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

19

Tojisha-Kenkyu in Practice: A Hypothetical Example Tojisha-Kenkyu 一個假設的例子

A 15-year-old autistic student says: "I suddenly cannot speak during group discussion."
一名15歲的自閉症學生說：“在小組討論時，我會突然說不出話。”

What happens to me?

我到底怎麼了？
My mind goes blank.
我腦子一片空白。
I can't tell when to speak.
我不知道什麼時候該說話。

When does it happen?

這種情況何時發生？
Overlapping voices 聲音重疊
Rapid topic changes 話題快速轉換
Unclear turn-taking 發言順序不明確

What patterns do we notice?

哪些模式需要留意？
Processing several voices 同時處理多個聲音
Monitoring several faces 同時關注多個臉孔
Worrying about interrupting 擔心打斷別人

Maybe I do have things to say. The difficulty is getting into this kind of conversation
或許我確實有些話想說，困難的是如何加入這類對話。

Key Reframing Process

重新定義流程的關鍵

From: Poor social skills

To: What person-environment fit produces the difficulty?

從「這個人的社交技巧不好」，重新理解為「個人與環境之間出現了什麼樣的不適配，才產生這項困難？」

Understanding changes the intervention target
瞭解改變會改變個案

What helps? 有哪些有效方法？

Questions in advance 提前提問
Explicit turn-taking 明確輪流發言
Smaller groups 小組討論
Written-response option 書面回答選項

20

“I Do Not Fully Know Myself”: From Lived Experience to Shared Knowledge 我並不完全了解我自己：從生活經驗到共享知識

Ayaya's (2025) premise – “I do not fully know myself.”

1. Knowledge is partial 每個人掌握的資訊都只是局部的
Self, Peers, Professionals/Clinicians, Families, or Teachers 自我、同儕、專業人士/臨床醫生、家庭或教師
--- No one sees everything! 沒有人能洞察一切!
2. Understanding is produced through dialogue 理解源自於對話
Lived Experience + Peer Experience + Clinical Knowledge + 生活經驗 + 同儕經驗 + 臨床知識 +
Family/Setting Knowledge >>> Shared Understanding 家庭/環境知識 >>> 共同理解
3. Who gets to produce knowledge? 誰有權利創造知識?
Participation means more than being heard; it includes influence over how problems and solutions are defined >>> Empowerment
參與不只是讓當事人的聲音被聽見，也包括讓當事人能影響問題與解決方案如何被界定。 >>> 賦權

Epistemic Injustice 知識不正義

People lack adequate language to describe experience that professional frameworks do not yet understand (Ayaya, 2025)
人們缺乏足夠的語言來描述專業框架尚未理解的經驗

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

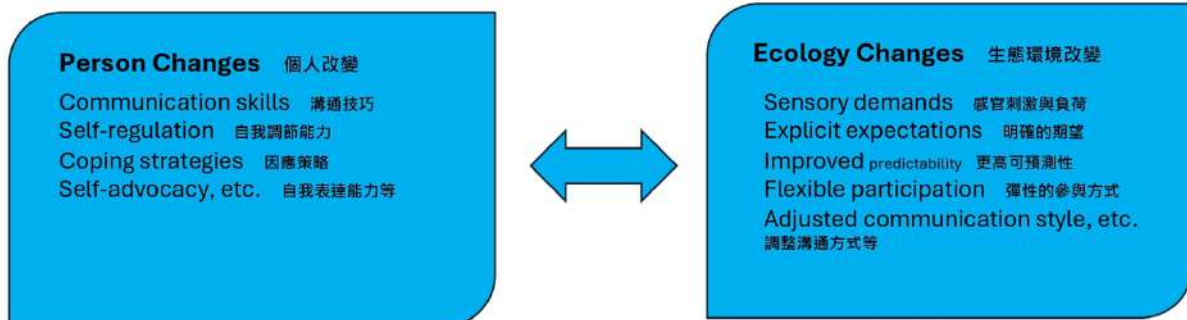
21

Reciprocal Adaptation: Who Should Change?

雙向調適：誰應該改變？

If understanding is collaborative, adaptation can be collaborative too.

如果理解是協作的，那麼適應也可以是協作的



Treatment and accommodation can work together.

治療和合理調整可以相輔相成

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

22

From Clinical Assessment to Ecological Assessment

從臨床評估到生態環境評估

Do Not Replace Clinical Assessment --- Add Context to It!

不是取代臨床評估，而是為臨床評估補充情境脈絡！

Move From:

What deficits does this person have?

To: Where does mismatch occur?

從「這個人有哪些能力缺損？」

轉向探問「個人與環境之間在哪些地方出現不匹配？」

***Four Ecological Questions** 四個生態學問題

Where does the person do well? 當事人在哪些環境中表現良好？

Where does the person struggle? 當事人在哪些環境中容易遇到困難？

What is different between those places? 這些環境之間有哪些差異？

What can we change in the setting before asking the person to change?

在要求當事人改變之前，我們可以先對環境做出哪些調整？

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

23

Taiwan: Beyond Services to Life in the Community

台灣展望：從「單純提供服務」走向「深耕社區生活」

Important Strengths Already in Place: 台灣已具備的重要優勢

- Developmental screening and assessment 完善的發展篩檢與聯評機制
- National health-care infrastructure 健全的全民健保醫療網絡
- Special-education provisions 特殊教育支持方案
- Early-interventions services 早期療育跨專業服務

What happens beyond early intervention? 離開早期療育階段後，支持如何持續？

e.g. School and Adolescence (Can support follow the person across settings?)

就學與青少年階段：支持資源能否跨場域、跨體系持續銜接與陪伴？

e.g. Adulthood and Work (Are accommodation and participation available?)

成年與就業階段：職場與社會是否具備合理的環境調整與實質工作參與機會？

e.g. Community Life (Can people develop relationships, belonging and meaningful roles?)

社區與社會生活：神經多樣性青年能否在社區中建立真實的人際關係、獲得社群歸屬，並發揮具意義的社會角色？

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

24

Taiwan: Beyond Services to Life in the Community

台灣展望：從「單純提供服務」走向「深耕社區生活」

Taiwan examples: 台灣本土實證研究

- Westby et al. (2024): gaps remain in some school-age/adults and school-based services
部分學齡期、成人期及校園支持服務仍有缺口
- Chen et al. (2026): urban-rural variations highlight differences in local ecology and access
城鄉差異反映出各地環境條件與服務可近性的不同

Good services are essential, but services alone do not guarantee belonging.

完善的專業服務固然是基石，但光有服務並不能保證帶來真正的社群歸屬感！

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

25

From Access to Belonging – and Contribution

從獲得資源邁向歸屬感與價值貢獻

Toward Communities of Belonging and Inclusion
邁向兼具歸屬感和包容性的社區



8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

26

“There’s No Place Like Home”: From Inclusion to Belonging

沒有任何地方比得上家：從形式包容邁向真正的歸屬

Can I be myself here? 我可以做我自己嗎？

Can I participate? 我可以參與嗎？

Do I belong? 我屬於這裡嗎？

Can I matter? 我的存在受到重視嗎？

Two Final Questions For Us All To Think About:

最後留給我們所有人共同深思的兩個關鍵提問

How can we help autistic people become better prepared for school, work, relationships, and community life?
我們該如何協助自閉症與神經多樣性青少年，更好地為就學、職場、人際關係與社區生活做好準備？

How can our schools, workplaces, clinics, families, and communities become better prepared for autistic people?
我們的學校、職場、醫療院所、家庭與社區，該如何為接納神經多樣性族群做好更完善的環境準備？

The future of autism support depends on both.

自閉症支持的未來，有賴個人與環境雙方共同做好準備！

8/24/26

Taiwan Adolescent Neurodiversity Int'l Symposium

27



Thank you!

謝謝聆聽

Toshi Sasao

International Christian University
Tokyo, Japan

Please contact me for any
comments or questions.

sasao@icu.ac.jp

8/24/26

28



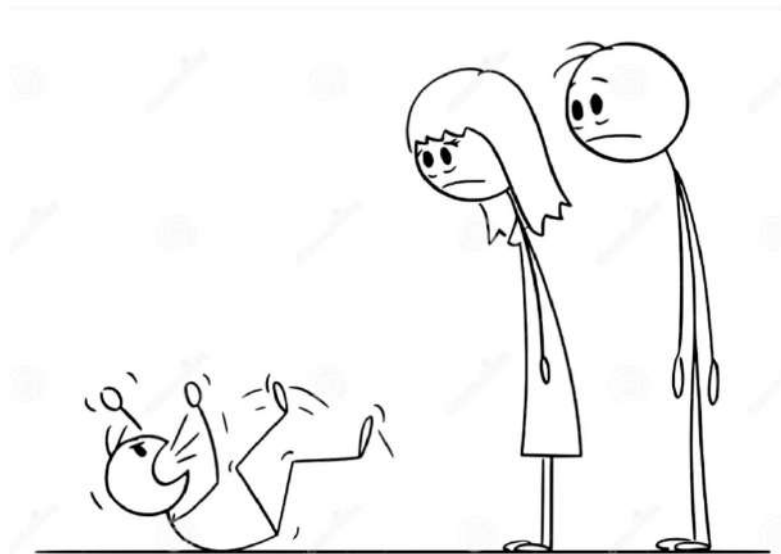
Welcome to Telos

歡迎來到Telos 全人中心



Why does residential treatment exist?

為什麼全日型住宿機構有其存在必要？



Where do our students come from?

我們的學生來自何方？



Assessment

個案全面評估



PSYCHIATRY

精神醫療整合評估



Residential 住宿生活



Academics 個別化課業學習



Therapy 專業臨床治療



RESIDENTIAL: ROOM, BOARD and SUPERVISION

住宿生活：日常食宿與生活照護



將生活衝突與情緒失調轉化為學習教育契機



ACADEMICS

個別化教學環境



Increase academic pressure by degrees

循序漸進提升課業要求



NeuroFitness
神經體適能訓練



Confidence is earned
靠自己贏得自信



What do we do over the weekends?

週末休閒運動治療



Students engage in meaningful service every week.

學生每週參與有意義的服務學習



Group therapy DBT
團體治療



Family therapy
家庭線上治療



Individual therapy
個別諮商



FINISH LINE

結案評估與後續銜接



SYNERGY

跨專業團隊協作





CHANGE

日常生活中實踐持續蛻變

The Telos Processing Approach

信息處理方法的諮商實務



A Relationship-Based Framework for Treatment
以關係為核心基礎的治療架構

Drew Davis, LCSW, Clinical Director, Telos

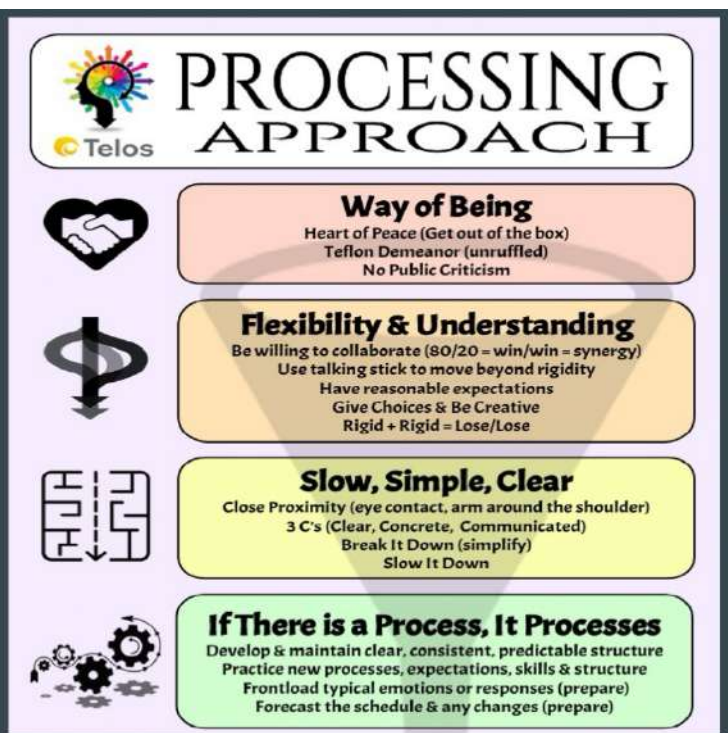
Why The Processing Approach Matters

為什麼「信息處理方法」至關重要

- Many adolescents struggle with regulation, executive functioning, and social understanding 許多青少年在情緒調節、執行功能與社交理解上面臨掙扎
- Escalation often occurs when expectations exceed current coping capacity 當外在要求超出孩子當前的因應容量時，衝突往往一觸即發
- Processing creates a bridge between emotion, understanding, and action 信息處理方法在情緒感受、認知理解與實質行動之間搭建了溝通橋樑
- Consistently using The Processing Approach reduces conflict and increases predictability 一致性地運用此模式能大幅減少衝突，並提升環境的可預測性

The Telos Processing Approach Telos

信息處理方法四大核心架構



What is The Processing Approach?

何謂「信息處理方法」模式

- A structured, relationship-based intervention
一套結構化、以關係為本的實務介入模式
- Designed to help neurodiverse students regulate, understand, and respond effectively
專為協助神經多樣性青少年學會調節、理解並做出有效回應而設計
- Focuses on teaching skills rather than enforcing compliance
聚焦於傳授生活技能，而非強迫服從
- Most effective when delivered early, calmly, and collaboratively
及早以冷靜、合作的方式介入時，最能發揮效果

The Telos Way of Being

Telos思維模式

- Maintain a Heart of Peace 保持內在平和
- Adopt a Teflon Demeanor: calm, unruffled, non-reactive
採取「不沾鍋式態度」：保持冷靜、沉著、不隨之起舞
- Avoid public criticism or humiliation 避免公開指責或使個案難堪
- Prioritize relationship before correction 先建立關係，再進行行為修正

Flexibility & Understanding

彈性與理解

- Collaborate rather than control 以合作取代控制
- Hold reasonable expectations 設定合理的期待
- Offer choices and creative alternatives when appropriate
提供合適的選擇與具創意的替代方案
- Seek win/win outcomes whenever possible 盡可能追求雙贏
- The goal is movement, not victory 目標是前進與改變，而非輸贏
- Power struggles rarely produce growth 權力鬥爭很少能帶來成長
- Adolescents often become more entrenched when they feel trapped
當青少年感到無路可退時，往往會更堅持原有立場

Slow, Simple, and Clear

放慢、精簡與明確

- Slow down the interaction 放慢互動步調
- Simplify the message 精簡話語訊息
- Communicate in clear language 使用清楚具體的語言
- Check for understanding rather than assuming it- Ask the adolescent to reflect what they heard
不要假設青少年已經理解；請他們用自己的話重述所聽到的內容
- Maintain eye contact, and use arm around the shoulder
保持眼神接觸，透過輕搭肩膀傳遞支持

If There is a Process, It Processes

當流程確立，就會水到渠成

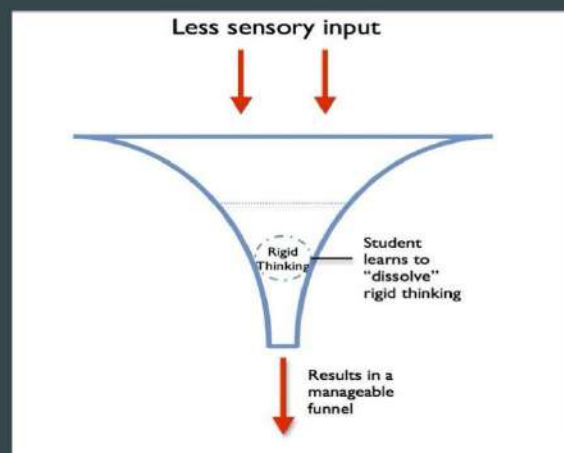
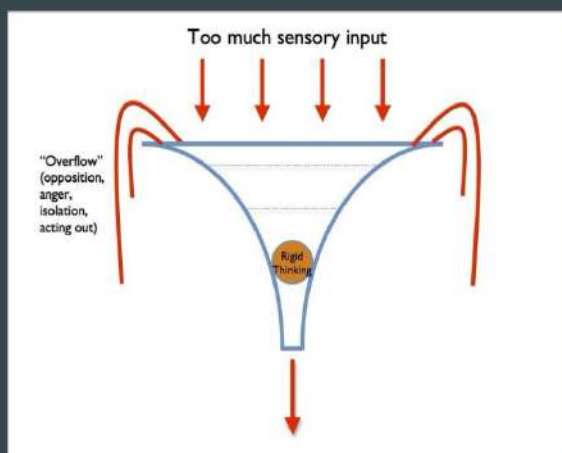
- Develop and Maintain, Clear, Predictable Structure
建立並維持清楚、可預測的結構
- Practice New Processes, Expectations, Skills, & Structure
反覆練習新的流程、期待與生活技能架構
- Frontload Typical Emotions or Responses (Prepare)
事先說明可能出現的情緒或反應，協助做好準備
- Forecast the Schedule & Any Changes (Prepare)
事前預告行程與任何可能的變動
- Maintain a calm, predictable response
保持冷靜且一致、可預期的回應方式

Core Principle: Mind the Funnel

核心原則：留意漏斗效應

- Do not process when a student is overwhelmed or highly frustrated
學生不堪負荷或高度挫折時，不宜立即進行信息處理
- Reduce stimulation and allow cooling off
優先降低刺激，給予冷靜的空間
- Move to one-on-one, non-confrontive interaction
改以一對一、非對抗的方式互動
- Recognize signs early and intervene before escalation
及早辨識預警訊號，在情緒升高前主動介入

The Funnel 情緒漏斗



Recognizing Warning Signs

認識常見情緒警訊模式

- Stuck or frustrated 卡住或感到挫折
- Stress sensitivity-Overwhelmed, often seen as anxious
壓力敏感：容易不堪負荷，且常表現出焦慮
- Not getting it 抓不到重點
- Disorganization- struggles with EF skills 組織規劃困難：執行功能較弱
- Social struggles- Timing, tact, tone, making friends, keeping friends
社交困難：互動時機、分寸、語氣、交朋友及維持友誼
- Difficulty with changes and transitions 適應變動與情境轉換困難

When to use The Processing Approach

信息處理方法使用時機

-Rigidity

固執僵化

-Stress Sensitivity

壓力敏感性

The Problem



Rigidity



Stress Sensitivity

Warning Signs

Stuck.

Frustrated.

Seeing things from one point of view.

Not willing to listen to an alternative perspective.

High Anxiety.

Avoidance.

Shut Downs.

Blow Ups.

Agitated State.

Warning Sign: Rigidity

警訊一：固執僵化

- Rigid thinking 思考僵化
- Seeing only one perspective 只能從單一角度看待事情
- Unwillingness to consider alternatives 不願考慮其他可能的選擇
- Increasing frustration during discussion 討論中情緒持續升溫

Skills for Rigidity

固執僵化因應技巧

- Use a turn-taking process so each person feels heard
運用輪流發言機制，確保雙方都被聽見
- Reflect back what was understood before responding
回應前，先覆述確認所理解的內容
- Focus on understanding before problem solving
解決問題前，先聚焦於相互理解
- Seek a win/win outcome when possible
盡可能追求雙贏結局

Warning Sign: Stress Sensitivity

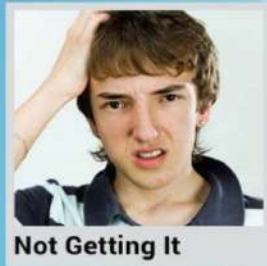
警訊二：壓力敏感性

- High anxiety 高度焦慮
- Avoidance 逃避退縮
- Shutdowns or blowups 情緒當機或情緒暴衝
- Feeling overwhelmed by responsibilities 對生活責任感到不堪負荷

Skills for Stress Sensitivity

壓力敏感性因應技巧

- Executive functioning supports 提供執行功能支持架構
- Task breakdown into manageable pieces 將任務拆解為可執行的小單元
- Soothing and regulation skills 教導自我安慰與情緒調節技巧
- Remove unnecessary stressors when appropriate 移除不必要的環境壓力源



Confused.

Student responds as though there is understanding, but not following through with expectations.



Can't find things.

Personal space is chaotic.

When to use The Processing Approach

信息處理方法使用時機

-Not Getting it

抓不到重點

-Executive Dysfunction

執行功能障礙

Warning Sign: Not Getting It

警訊三：抓不到重點

- Confusion despite appearing to agree 表面答應但實際上困惑
- Off-the-mark responses 答非所問
- Difficulty following through with expectations 難以按照要求持續完成任務
- Misunderstanding instructions 誤解指令

Skills for Not Getting It

抓不到重點因應技巧

- Break the information down into simple language
將訊息拆解為簡潔直白的語言
- Black and white clear instructions 提供清楚明確、毫不模糊的指令
- Ask for them to reflect back what they heard
請對方用自己的話重述所聽到的內容

Warning Sign: Disorganization

警訊四：組織規劃困難

- Cannot find needed items 找不到所需物品
- Chaotic personal space 生活空間雜亂無章
- Difficulty managing belongings 個人物品難以管理
- Frequent forgetting 經常遺忘事情

Skills for Disorganization

組織規劃困難的因應技巧

- Daily check systems 建立每日檢查確認機制
- Simplifying belongings 精簡個人物品
- Clear storage routines 建立清楚固定的收納流程
- Increase responsibility gradually as success improves
隨著成功經驗累積，逐步增加其應負的責任

When to use The Processing Approach

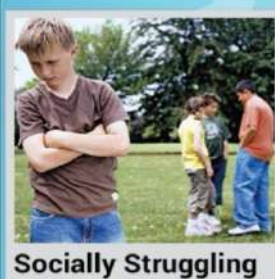
信息處理方法使用時機

-Social Struggles

社交困難

-Changes and Transitions

適應變動與轉換



Makes 'off the mark' comments.

Timing, tact and tone is off.

Gets alienated by peers.

Student looks for reassurance about the day's plan.

Student becomes agitated by a change in plan.

Warning Sign: Social Struggles

警訊五：社交困難

- Poor timing, tact, or tone 互動時機、分寸或語氣不恰當
- Misreading social situations 誤判社交情境
- Peer alienation 疏離同儕
- Difficulty adjusting behavior to context 難以根據情境調整行為

Social Skill Coaching

社交技能輔導實務

- Teach one skill at a time 一次聚焦教導一項技能
- Practice repeatedly across settings 在不同情境中反覆練習
- Provide immediate, specific feedback away from others
私下給予即時、具體的引導回饋
- Model the desired interaction 示範期望的社交互動模式

Warning Sign: Changes & Transitions

警訊六：適應變動與轉換困難

- Repeated reassurance seeking 反覆尋求確認與保證
- Agitation when plans change 計劃變動時的焦躁不安
- Difficulty moving between activities 活動切換困難
- Escalation around uncertainty 面對不確定性時，情緒逐漸升高

Skills for Problems with Changes and Transitions

變動與轉換困難因應技巧

- Prepare students for upcoming events and changes 提前預告即將發生的事件與變動
- Anticipate emotional reactions before they occur 預先預想可能出現的情緒反應
- Reduce uncertainty, especially during transitions 降低轉換過程中的不確定性
- Give extra time to processing when plans change unexpectedly
遇到突發事件，給予充裕的時間進行調適與梳理

Processing Change Effectively

有效因應變化的作法

- Forecast the day's plan 事前預告當日流程規劃
- Frontload expected changes 事先說明預期會出現的變動
- Provide extra time to digest unexpected changes
面對突發變動時，給予更多時間理解與消化
- Maintain a calm, predictable response 保持冷靜、可預測的應對措施

Key Takeaways

重點總結

- Relationship first 關係永遠優先
- Process early rather than late 及早進行信息處理，不要等到情緒升高
- Stay calm and non-reactive 保持冷靜，不隨情緒起舞
- Keep communication slow, simple, and concrete
溝通時放慢速度，並保持簡潔、具體
- Teach skills, not just compliance 教導生活技能，而非只要求服從

How to get the most out of Therapy

如何提升諮商治療的參與及效益

Barry Fell LCSW

**The goal of therapy is not to make you dependent
on your therapist**

治療的目標不是讓你依賴你的治療師

**The people who benefit most understand that
therapy is not something that is done to them**

獲益最多的人深刻明白：心理治療不是一件被動接受、由別人替自己完成的事

Come With a Purpose

帶著明確的目標而來

Be Completely Honest

完全坦誠

Be Willing to Learn

抱持樂於學習的心態

Expect Discomfort

做好面對不適與挑戰的心理準備

Choosing the Right Therapist—and Becoming the Right Client

選擇合適的治療師 — 也讓自己成為主動投入治療的個案

Can I trust this person?

我能夠信任這個人嗎？

Does my therapist have a clear process?

我的治療師是否具備明確的治療架構與流程？

Am I changing?

我是否開始改變？

**The goal of therapy is not to become dependent
on your therapist.**

**The goal of therapy is to become increasingly
capable without one.**

治療的目標，不是讓你依賴治療師；
治療的目標，是讓你即使沒有治療師，也能逐漸具備獨立應對的能力。

INFLUENCING ADOLESCENTS THROUGH RELATIONSHIPS, UNDERSTANDING, AND SKILL DEVELOPMENT

如何透過建立關係、理解和技能培養促進影響青少年

The Pyramid of Influence: Choosing the Right Response in the Moment

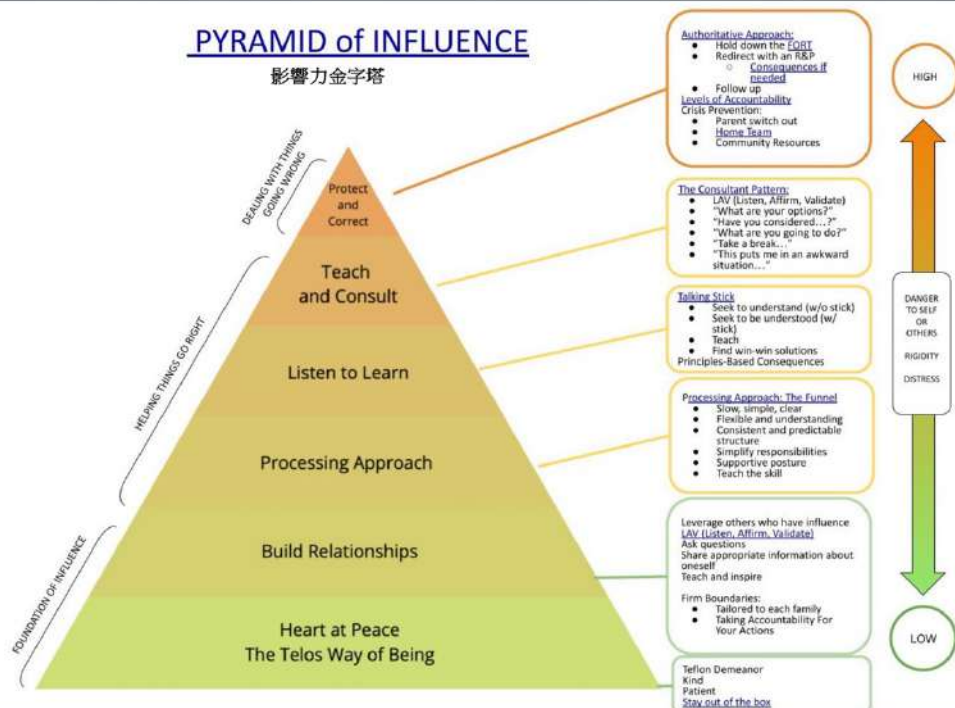
影響力金字塔：在當下選擇適切的回應策略

Drew Davis, LCSW · Clinical Director, Telos

1

PYRAMID of INFLUENCE

影響力金字塔



2

ABOUT THIS SESSION 本節核心目標

Who We Are, What We'll Cover

我們是誰・我們要做什麼

- Our staff work face-to-face, every day, with young people learning to regulate, connect, and grow — many diagnosed with ASD, ADHD, or otherwise neurodivergent
我們工作人員每天與青少年面對面交流，幫助他們學習如何調節情緒、與人建立關係和自我成長——其中許多青少年被診斷出患有自閉症、注意力不足過動症或其他神經多樣性問題

THREE THINGS TO WALK AWAY WITH TODAY 離開時要記住的三件事

- Why our response to behavior has to change along with a young person's nervous-system state
為什麼我們的回應必須隨著青少年神經系統狀態而調整？
- The six tiers of the Pyramid of Influence, and what each one asks of us
影響力金字塔的六個層級，以及每一層我們該做的事
- How to choose the right tier, in the moment, for the adolescent in front of you
如何依照青少年當下的具體情況，精準選擇適合的層級



3

THE PROBLEM 核心問題

One Chart Doesn't Fit Every Brain

單一套行為計畫無法適用於每一位青少年

- Most behavior plans assume a calm, reasoning brain is always available
大多數行為計畫都假設孩子大腦可以隨時保持冷靜和理性思考
- In sensory overload or shutdown, that reasoning brain can be temporarily offline — no matter how clear the rule or consistent the consequence
在感官超載或大腦關閉的情況下，無論規則多麼清晰或後果多麼一致，大腦理性都可能暫時離線
- So we end up doing things that feel logical but backfire: the same consequence regardless of state, verbal reasoning mid-meltdown, reading rigidity as defiance
因此，我們最終會做出一些看似合乎邏輯但卻適得其反的事情：無論對方處於何種狀態都採取相同的後果，在情緒崩潰時當下試圖講道理，將固著僵化誤解為故意反抗
- What actually works: read the physiological state first, then match our response to the level of distress in front of us
真正有效的方法是：先解讀生理狀態，然後根據孩子當下的痛苦程度調整我們的反應

4

CORE CONCEPT 核心概念

Capacity Is State-Dependent

個案能力取決於當下身心狀態

- A regulated nervous system can listen, reflect, and choose
一個運作正常的神經系統能夠聆聽、思考和做選擇。
- A dysregulated nervous system is doing something else entirely — it's focused on survival
而一個失調的神經系統則完全不同——它只專注於生存。

REGULATED 正常狀態

Calm, connected, able to reflect
平靜、能建立連結、能自我反思

RISING 情緒升溫

Anxious, overwhelmed, harder to reach
焦慮、不堪負荷、溝通難以觸及

ACTIVATED 情緒失控

Danger to self or others, rigidity, distress
對自身或他人構成危險、僵硬、痛苦

Our job is not to master one technique and use it on every adolescent — it's to recognize which state we're looking at, and respond accordingly. 我們的工作不是掌握一種技巧並將其應用於每個青少年，我們的工作是辨識當前狀態，並做出適切回應。

5

READING THE STATE 解讀個案身心狀態

What to Look For

觀察指標

Before the tiers: three seconds reading the body tells you more than the words being said
在金字塔分層級之前：三秒鐘迅速觀察肢體語言，它將提供比個案說什麼本身更多的資訊

REGULATED 正常狀態

- Steady, even breathing
呼吸平穩
- Normal voice pitch and pace
正常的語調和語速
- Eye contact comes and goes
眼神交流時有時無
- Can shift and reconsider
能轉換想法並重新思考

RISING 情緒升溫

- Faster, shallower breathing
呼吸短促
- Voice speeds up or flattens
語速加快或語調變得平緩
- Fidgeting, pacing, or stillness
坐立難安、踱步或靜止不動
- Answers shorten or repeat
回答簡短或重複

ACTIVATED 情緒失控

- Raised voice, aggressive posture
音量提高、擺出攻擊性姿態
- Refuses every instruction
拒絕指令
- ...or goes completely silent
或者完全沉默
- Freeze can look like calm
僵住可能看起來很平靜

Read the body before you respond to the words. 在回應之前，先花一點時間讀懂對方身體訊息

6

READING THE STATE 解讀個案身心狀態

Fight, Flight, or Freeze

三種防衛反應：對抗、逃跑與靜止不動

An activated nervous system doesn't always look the same — it shows up as one of three patterns.
情緒失控神經系統並不總是以相同的方式呈現，而可能表現為以下三種模式：

FIGHT 對抗

- Yelling, throwing, squaring up
大喊大叫、丟東西、擺出架勢
- Refuses outright 斷然拒絕
- Easy to recognize — it's loud
很容易辨認——聲音很大

FLIGHT 逃跑

- Bolting, pacing, needing to move
突然跑開、來回踱步、或不斷想移動
- Leaves the conversation
逃離對話
- Often misread as disrespect
常被誤解為不尊重

FREEZE 僵住不動

- Stillness, silence, flat affect
靜止、沉默、面無表情
- No eye contact
沒有眼神交流
- Often misread as calm or defiant
常被誤解為冷靜或故意挑釁

A quiet room is not always a calm room. 安靜的房間並不等於是平靜的房間

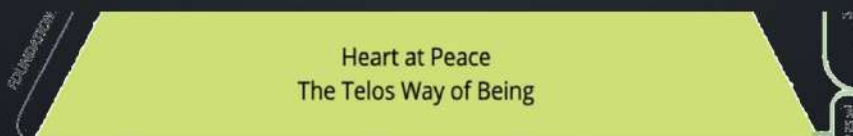
7

TIER 1 OF 6

Heart at Peace

第一層：平靜的內心

- Foundation of the pyramid — part of the Telos Way of Being
金字塔的根基——Telos思維模式
- A dysregulated adult cannot co-regulate a dysregulated adolescent
一個情緒失調的成年人無法幫助一個情緒失調的青少年進行情緒調節
- Teflon Demeanor: kind, patient, calm, respectful — so nothing sticks
展現不沾鍋態度：溫和、耐心、平靜、尊重，不被情緒言語牽動
- Get this tier right, and you're ahead of where most well-meaning adults start
如果這一層級處理得當，你就已經超越了大多數人的起點



8

IN PRACTICE

In Practice: Heart at Peace

平靜的內心實務案例

The Moment: A student escalates over a routine transition — device away, time for group.

場景：一名學生在常規轉換時——收手機、開始上課——開始情緒激動

Our Response: Staff lowers his own voice, slows his breathing, and waits.

回應措施：工作人員主動降低音量、放慢呼吸、平靜等待

The Result: The student's voice drops to match his — in under a minute.

結果：學生在一分鐘內跟著降低音量

Our calm was the intervention, before any other tier was needed.
在需要運用其他層級的策略之前，工作人員保持平靜本身就是一種介入。

9

TIER 2 OF 6

Build Relationships

第二層：建立關係

- Connection creates influence — influence, not compliance, changes behavior
情感連結創造影響力；是影響力而非強迫服從帶來行為改變
- PRIDE skills: Praise, Reflect, Imitate, Describe, Enjoy
練習PRIDE技巧：讚美、覆述、**模仿**、描述、享受相處
- LAV — Listen, Affirm, Validate — alongside firm, respectful boundaries
練習LAV技巧：傾聽、肯定、同理**接納**情緒，並維持堅定界限
- We show we care before we ask for change
我們在提出孩子改變要求之前，先展現關心



10

IN PRACTICE

In Practice: Build Relationships

建立關係實務案例

The Moment: A new student arrives guarded — arms crossed, one-word answers.

場景：一位新學生帶著防衛心 - 雙手交叉抱在胸前，回答問題也總是只用一個字

Our Response: Weeks of PRIDE skills: praise, reflect, describe — showing up, without pushing.

回應措施：連續數週運用 PRIDE 技巧耐心同在、不強推要求

The Result: He asks, unprompted, whether staff will be there again tomorrow.

結果：學生主動詢問工作人員明天是否還會來帶團體

That question was relationship — and everything else had somewhere to land.

學生主動提出這個問題，代表彼此的關係已經開始建立，也讓後續的支持與引導有了基礎。

11

TIER 3 OF 6

Processing Approach

第三層：信息處理方法

- Sits deliberately in the middle — not our first move, not our last resort
位於金字塔的中間層級——既不是第一步，也不是最後手段
- Used once a student has moved past baseline calm, before things escalate
在學生情緒開始偏離平穩狀態、但情勢尚未升高之前
- Slow, simple, clear language. Flexible, understanding posture
說話放慢、簡潔明確的語言、保持彈性與理解
- Consistent, predictable structure — teach the skill, don't just name the deficit
前後一致、可預測架構——教導技能，而不僅僅是指出不足
- A rising-state tool: most powerful right before a crisis, not after
一種情緒升溫期的工具：在危機發生前最有效，而非危機發生後



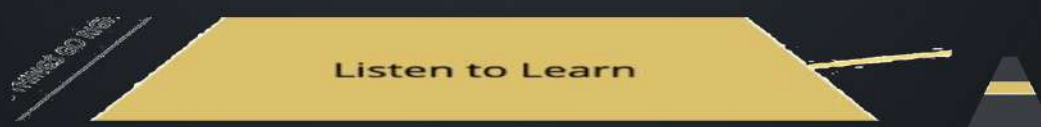
12

TIER 4 OF 6

Listen to Learn

第四層：聆聽以理解

- Before we teach, we listen — genuinely curious, not furious
教導之前，我們先傾聽——帶著真誠的好奇，而非憤怒
- The Talking Stick: a visual cue for whose turn it is to speak
發言棒機制：提供輪流發言的視覺結構
- Ask open questions; validate the emotion before addressing the behavior
提出開放式問題；在處理行為之前，先認同對方的情緒
- Look for win-win solutions, grounded in principles, not punishment
尋找基於原則而非懲罰的雙贏解決方案



13

IN PRACTICE

In Practice: Listen to Learn

聆聽學習實務案例

The Moment: A student demands that a peer be moved to another group.

場景：一名學生要求將同學調到另一個小組

Our Response: Staff picks up the Talking Stick and asks, "Tell me what happened."

回應措施：工作人員拿起發言棒詢問：“告訴我發生了什麼事”

The Result: The real issue was feeling excluded at lunch — not the peer at all.

結果：真正的問題是午餐時感到被排斥——根本不是針對那位同學

Behavior is communication. We can't respond to a message we never heard.

行為也是一種溝通。如果沒有聽見行為所傳達的訊息，我們就無法作出適切的回應。

14

TIER 5 OF 6

Teach and Consult

第五層：教導與諮詢

- Move from listening into teaching — as a consultant, not a director
從傾聽轉變為教導 - 扮演顧問的角色，而非指揮官
- “What are your options?” “What are you going to do?”
引導提問：「你有什麼選擇？」、「你打算怎麼做？」
- Solve problems together; offer real choices; teach the skill directly
共同解決問題；提供切實可行的選擇；直接教導技能
- Builds self-advocacy skills that matter after we've left the room
培養即使支持者不在場，仍能持續運用的自我表達能力



15

IN PRACTICE

In Practice: Teach and Consult

教導與諮詢實務案例

The Moment: A student misses the same homework assignment four weeks running.

場景：一名學生連續四週未完成同一項作業

Our Response: Staff asks, 'What are your options?' — not, 'Here's what you'll do.'

回應：老師會問「你有什麼改善方案？」，而不是「你必須這樣做」

The Result: He builds his own checklist system, and starts using it.

結果：他建立了自己的檢查清單系統，並開始使用它

It worked because it was his plan — building the self-advocacy that outlasts us.

這個方法之所以有效，是因為這是學生自己提出的方案，也讓他逐漸培養出即使工作人員不在身邊，仍能為自己作決定並採取行動的能力。

16

TIER 6 OF 6

Protect and Correct

第六層：保護與修正

- The smallest tier — and it should stay that way
金字塔中最小的一層 - 而且應該保持最低層級
- Used for danger to self or others, extreme rigidity, or acute distress
用於自傷或傷人、極度固執或極度痛苦的情況
- May mean switching staff, removing an audience, or contacting authorities
可能意味著更換工作人員、請旁觀者離開 / 清空現場或必要時通報聯繫相關部門支援
- Always followed by a debrief — for connection and rebuilding
事後必定進行修復晤談以重建關係與安全感
- Spending most of your time here is a sign something below was missed
大部分時間都待在這裡 - 表示你忽略了下面某些重要的事情



17

PROTECT AND CORRECT

De-Escalating in the Moment

即時緩和衝突局勢

- Be empathic and nonjudgmental — the feeling is real even when the behavior **isn't**
要有同理心 - 不要妄加評斷——即使行為不恰當 - 感受仍然是真實的
- Respect personal space — watch your own positioning and proximity
尊重個人空間 - 注意自己的站位和距離
- Use nonthreatening body language — tone and posture say more than words
使用不具威脅性的肢體語言 - 語氣和姿態勝過千言萬語
- Keep your own emotional brain in check — your calm makes de-escalation possible
控制好自己情緒 - 保持冷靜有助於緩和局勢
- Don't engage a challenging question — redirect back to the issue, not the argument
不要回應棘手問題——引導對方回到問題本身 - 而不是爭論
- Set limits that are simple, respectful, and few
設定簡單、尊重且數量有限的界線
- Allow silence and time — a few extra seconds can be the difference
允許沉默和時間——幾秒鐘的額外時間可能決定成敗

18

WHEN IT BECOMES PHYSICAL

Who Does What — and Who to Call

肢體衝突危機因應與角色分工

PARENT 家長

Clear other children from the room, lower your voice and create space, and call your partner or another adult for backup before you're in over your head

帶其他孩子離開現場、降低音量保持距離、呼叫其他夥伴幫忙支援

TEACHER 老師

Use your school's call-for-support signal early, clear the room, and loop in an administrator immediately — never handle this solo

及早發出支援訊號、疏散學生、通報行政主管

THERAPIST 治療師

Follow your agency's crisis protocol, clear other clients from the space, and call a supervisor — or 911 if there's real danger

啟動危機程序、疏散其他個案、通報主管或報警

Verbal first. Support early. Hands-off whenever possible — always followed by a debrief.

先口頭溝通。儘早提供支援。儘可能避免肢體介入。但事後一定要進行狀況報告。

19

IN PRACTICE

A Crisis Moment, Three Responses

危機應對實務案例

TEACHER 老師

State: a student flips his desk, throws a book, and squares up toward a classmate — danger to others **Response:** signal for backup right away, clear the surrounding students calmly, keep a level voice, and hand off to the administrator before debriefing.

事件描述：一名學生掀翻課桌，丟出一本書，並擺出攻擊同學的架勢——對其他同學構成危險。因應措施：立即發出支援訊號，冷靜疏散周圍學生，保持語氣平和，並在事後報告前將情況移交給校方管理人員。

PARENT 家長

State: your teenager slams a door, punches the wall, and says she wants to hurt herself — a safety crisis, not a tantrum

Response: get other children out, keep your voice and body calm, call your partner or another trusted adult, and call emergency services if there's real risk.

說明：你的青少年摔門、捶牆，並說她想傷害自己——這是安全危機，而非發脾氣。因應措施：帶其他孩子離開，保持語氣和肢體冷靜，打電話給你的伴侶或其他可信賴的成年人，如果有真正的危險，請撥打緊急服務電話。

THERAPIST 治療師

State: a client stands up, throws a chair, and blocks the door — escalated, between you and the exit. **Response:** trigger your agency's crisis protocol, call for another staff member, stay near the exit, and call police if there's real danger.

事件描述：一位個案站起來，丟出一張椅子，堵住了門口——事態升級，擋在你和出口之間。因應措施：啟動機構危機處理流程，呼叫其他工作人員，待在出口附近，如果有真正的危險，請報警。

20

THE KEY IDEA 核心思維

Match the Tier to the Physiological State

將層級配對至符合生理狀態

- The behavior in front of us doesn't tell us which tier to use — the nervous-system state underneath it does
眼前的行為並不能告訴我們應該使用哪一層級的應對機制——背後的神經系統狀態才能
- Rigidity and shutdown belong in the same conversation as an outburst — both can signal high arousal
固執和封閉與情緒爆發應該放在同一討論範圍內——兩者都可能表明高度發達

LOW — REGULATED 正常狀態

Heart at Peace · Build Relationships · Processing Approach
內心平靜 · 建立關係 · 信息處理方法

RISING 情緒升溫

Processing Approach · Listen to Learn
信息處理方法 · 聆聽學習

HIGH — DANGER, RIGIDITY, DISTRESS 情緒失控

Teach and Consult · Protect and Correct
教導與諮詢 · 保護與修正



21

IN PRACTICE

One Afternoon, Four Tiers

四個層級實務應用

1 Processing Approach 信息處理方法

State: sensory overload, overwhelmed by noise and demands

狀態：感官超載，被噪音和請求壓得喘不過氣

Response: simplify instructions, break tasks down, lower demands

因應措施：簡化指令，分解任務，降低要求

2 Listen to Learn 聆聽學習

State: rigid, refuses to move, locked up (not defiant)

狀態：固執，拒絕行動，封閉（非反抗）

Response: get curious, not furious — Listen to Learn

因應措施：保持好奇，而非憤怒 - 傾聽學習

3 Teach and Consult 教導與諮詢

State: a brief, safe window opens, more receptive

狀態：出現一個短暫、安全且較能溝通的時機，更容易接受

Response: offer two clear choices instead of a lecture

因應措施：提供兩個明確的選擇，而不是說教

4 Build Relationships 建立關係

State: calm again, regulated

狀態：再次平靜，情緒穩定

Response: a short reconnection to close the loop

因應措施：透過簡短的重新連結為事件收尾

Four tiers. One afternoon. No crisis needed. 一個下午，運用四個層級，無須等到危機發生

22

TAKEAWAYS

What to Carry Home

總結要點

- State comes first — read the nervous system before you choose your response, not the other way around
生理狀態永遠優先：先判斷神經系統再選擇回應策略
- Rigidity is a signal, not defiance — shutdown and outburst can share the very same root
固著僵化是一項訊號，而非故意反抗；封閉與情緒爆發可能有相同根源
- Protect and Correct is the exception, not the rule — it's the smallest tier for a reason
保護與修正只是特例，絕非普遍情況。它之所以位於金字塔最小的一層，是有原因的。

Our overall goal, underneath all six tiers: helping every adolescent build self-control, responsibility, and healthy relationships — on terms that actually fit how their brain works.

貫穿這六個層級的共同目標，是以真正符合每位青少年大腦運作方式的方法，協助他們培養自我控制、責任感與健康的人際關係。

23

TAKEAWAYS

What to Carry Home

總結要點

STATE → RESPONSE, AT A GLANCE 狀態 → 回應概覽

- **Fidgety and overwhelmed** → Processing Approach — simplify, slow down, lower demands
焦躁不安、不知所措 → 處理方法 — 簡化流程、放慢速度、降低要求
- **Rigid and refusing** → Listen to Learn — get curious, not furious
固執拒絕 → 傾聽學習 — 保持好奇心，而非憤怒
- **Shut down and silent** → Teach and Consult — offer real choices, problem-solve together
封閉沉默 → 教導與諮詢 — 提供實際可行的選擇，共同解決問題
- **Danger to self or others** → Protect and Correct — safety first, call for support, debrief after
對自己或他人構成危險 → 保護與修正 — 安全第一，尋求支持，事後進行總結

Our overall goal, underneath all six tiers: helping every adolescent build self-control, responsibility, and healthy relationships — on terms that actually fit how their brain works.

貫穿這六個層級的共同目標，是以真正符合每位青少年大腦運作方式的方法，協助他們培養自我控制、責任感與健康的人際關係。

24

Thank You
謝謝聆聽

Drew Davis, LCSW · Clinical Director, Telos

25



台灣兒童青少年 神經多樣性第三屆國際研討會

Third Taiwan Children and Adolescent
Neurodiversity International Symposium

主辦單位 亞東紀念醫院 (神經醫學部、家庭醫學部、精神暨心身醫學部)、新北市政府社會局
台灣青少年神經多樣性行動協會、國教行動聯盟

協辦單位 新北市政府衛生局、新北市政府教育局、台灣青少年醫學暨保健學會、全國家長會長聯盟、
社團法人新北市教師會、臺灣輔助醫學醫學會、臺灣心理治療學會、社團法人全國家長教育志工聯盟、
新北市中小學家長會長協會、社團法人中華民國社會工作師公會全國聯合會、家庭韌性行動聯盟、
任林教育基金會、台灣全國媽媽護家護兒聯盟、臺灣兒童早期療育福利協會、
中華育幼機構兒童關懷協會 (CCSA)、社團法人中華民國諮商心理師公會全國聯合會
中華民國臨床心理師公會全國聯合會、財團法人赤子心教育基金會